INTÉGRER LES PERSPECTIVES INTERSEXUÉES DANS LES POLITIQUES DE SANTÉ POUR DES PRATIQUES INCLUSIVES AU NIGÉRIA

(Un guide des politiques et des pratiques à l'intention des professionnels de la santé et des décideurs politiques)

Obioma Chukwuike
Intersex Nigeria
(Center for Healthcare Development and Youth Empowerment)

intersex
NIGERIA
CENTER FOR HEALTHCARE DEVELOPMENT & YOUTH EMPOWERMENT

© 2025 Obioma Chukwuike. Tous droits réservés.

Cette publication, « Intégrer les perspectives intersexuées dans les politiques de santé pour une pratique inclusive au Nigéria », est l'œuvre d'Obioma Chukwuike.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, distribuée ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre) sans l'autorisation écrite préalable de l'auteure, à l'exception de brèves citations utilisées à des fins de plaidoyer, de recherche, d'éducation et à des fins non commerciales, avec mention de la source.

Auteure:
Obioma Chukwuike
Fondatrice et directrice générale d'Intersex Nigeria
Présidente du conseil d'administration du Mouvement africain des personnes intersexuées (AIM)

Éditeur :
Intersex Nigeria
(Centre pour le développement des soins de santé et l'autonomisation des jeunes)

Première édition: 2025
Conçue et produite au Nigéria.

Avertissement:
Les opinions exprimées dans cette publication sont celles de l'auteure et des contributeurs et ne reflètent pas nécessairement les politiques ou positions officielles des organisations partenaires.

Pour toute demande d'autorisation, de partenariat ou de renseignements:
info@intersexnigeria.org

Remerciements

Je suis profondément reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de participer au programme de bourses 2023 des Nations Unies sur les droits et la religion organisé par Outright International. Ce programme a renforcé mon travail de défense et de création de connaissances et m'a fourni une plateforme puissante pour amplifier les droits et l'inclusion des personnes intersexuées au Nigeria et dans le monde entier.

Dans le cadre de cette bourse, j'ai collaboré avec des personnes intersexuées au Nigeria afin d'élaborer une boîte à outils complète intitulée « Intégrer les perspectives intersexuées dans les politiques de santé pour des pratiques inclusives au Nigeria », qui vise à aider à intégrer les perspectives intersexuées dans les politiques et les pratiques de santé à l'échelle nationale. Cette boîte à outils offre des conseils pratiques aux prestataires de soins de santé sur la manière de prodiguer des soins respectueux et appropriés, permet aux institutions gouvernementales et aux décideurs politiques de comprendre les défis uniques auxquels sont confrontées les personnes intersexuées, et souligne la nécessité d'une législation qui protège les droits et la dignité des personnes intersexuées.

Je tiens à exprimer ma gratitude à Outright International pour son soutien indéfectible et son leadership mondial, ainsi qu'à toutes les personnes intersexuées et à tous leurs alliés qui ont contribué à ce travail. Je remercie tout particulièrement Kimberly Zieselman pour sa relecture attentive et ses conseils éditoriaux. Je suis honorée d'avoir rédigé un document qui, je l'espère, aidera les professionnels de santé, les institutions gouvernementales et les organisations de la société civile à mettre en place un système de santé plus inclusif au Nigeria.

Ensemble, continuons à faire progresser les droits et la dignité des personnes intersexuées en oeuvrant pour un avenir où chacun, quel que soit son statut intersexué, sera traité avec équité, respect et égalité au Nigeria.

Avec toute ma gratitude,

Obioma Chukwuike
Directeur exécutif
Intersex Nigeria (Center for Healthcare Development and
Youth Empowerment)

Table des matières

REMERCIEMENTS

SECTION 1 — À PROPOS DE CETTE BOÎTE À OUTILS....3

Introduction....3
Objectif....3
Public Cible....4

SECTION 2 — COMPRENDRE LES RÉALITÉS INTERSEXUÉES....7

Comprendre l'Intersexualité....7
Mythes Courants Sur l'Intersexualité Et Faits Réels....8
Intersexualité Et Genre....10
Aperçu Des Principales Questions Liées À l'Intersexualité....11

SECTION 3 — DROITS HUMAINS ET CONTEXTE JURIDIQUE....13

Cadres Juridiques Et Éthiques....13
Le Contexte Juridique Nigérian....18

SECTION 4 — DÉFIS DU SYSTÈME DE SANTÉ NIGÉRIAN....19

Services De Santé Inclusifs....19
Santé Mentale Et Bien-Être....21
Éthique Et Consentement....24

SECTION 5 — ÉLABORATION DE POLITIQUES INCLUSIVES POUR LES PERSONNES INTERSEXUÉES...26

Principes Clés De l'Élaboration De Politiques Inclusives....26
Participation Des Parties Prenantes....27
Conception Et Mise En Oeuvre De Politiques Relatives Aux Personnes Intersexuées....28
Exemples De Bonnes Pratiques En Matière De Politiques Relatives Aux Personnes Intersexuées....29

SECTION 6 — OUTILS PRATIQUES....31

Lignes Directrices À l'Intention Des Prestataires De Soins De Santé....31
Recommandations À l'Intention Des Organismes Gouvernementaux....31
Appel À l'Action Pour Les Osc....34

SECTION 7 — CONCLUSION ET ANNEXES....35

Conclusion....35
Annexes....38

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES....39

SECTION 1 — À Propos de Cette Boîte à Outils

Introduction

Les personnes intersexuées sont des individus qui naissent avec des variations innées au niveau de leurs chromosomes, de leurs hormones ou de leur anatomie reproductive, qui se manifestent par des variations des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux notions binaires typiques des corps masculins ou féminins.

Pour créer une société inclusive qui embrasse la diversité, nous devons répondre aux besoins et aux défis uniques auxquels sont confrontées les personnes intersexuées dans le système de santé Nigérian.

Objectif

L'objectif de cette boîte à outils, qui s'adresse aux prestataires de soins de santé, aux institutions gouvernementales, aux décideurs politiques et aux organisations de la société civile (OSC), est de sensibiliser et de fournir des conseils sur l'intégration des perspectives intersexuées dans les politiques de santé afin de mettre en place des pratiques inclusives. Elle vise à répondre aux besoins et aux expériences spécifiques des personnes intersexuées dans le système de santé nigérian, en veillant à ce que leurs droits à la dignité, à l'autonomie corporelle et à la non-discrimination soient respectés et protégés.

Grâce à cette boîte à outils, les prestataires de soins de santé disposeront de meilleures connaissances et orientations pour fournir des soins appropriés et inclusifs aux patients intersexués. Elle présentera les meilleures pratiques en matière de diagnostic et de soutien, tout en tenant compte des préoccupations et des défis spécifiques auxquels sont confrontées les personnes intersexuées en matière de santé. En outre, la boîte à outils soulignera l'importance du consentement éclairé et fournira des lignes directrices sur la participation des personnes intersexuées aux processus décisionnels concernant leurs propres soins de santé.



Les institutions gouvernementales et les décideurs politiques jouent un rôle crucial dans l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques de santé qui répondent aux besoins de tous les citoyens, y compris les personnes intersexuées. Cette boîte à outils servira de ressource pour éclairer l'élaboration et la réforme des politiques, en veillant à ce que les perspectives des personnes intersexuées soient intégrées dans les politiques de santé afin de promouvoir l'inclusion et de protéger les droits des personnes intersexuées.

Les organisations de la société civile qui défendent les droits et le bien-être des personnes intersexuées peuvent utiliser cette boîte à outils pour renforcer leurs efforts. Elle leur fournira des informations fondées sur des données probantes et des recommandations

pratiques pour faire pression en faveur de changements politiques et sensibiliser le public aux questions liées à l'intersexualité. En collaborant avec les prestataires de soins de santé, les institutions gouvernementales et les décideurs politiques, les organisations de la société civile peuvent oeuvrer à la création d'un système de santé sensible, respectueux et inclusif des besoins spécifiques des personnes intersexuées au Nigeria.

Public Cible

1. Les agences et institutions gouvernementales, qui jouent un rôle crucial dans l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques visant à promouvoir l'inclusion des personnes intersexuées au Nigeria.

2. Les OSC, qui sont des défenseurs très importants des droits des groupes marginalisés et vulnérables, y compris les personnes intersexuées, et qui contribuent grandement à façonner l'opinion publique et à autonomiser les personnes intersexuées.

3. Les praticiens médicaux, qui sont les premiers prestataires de soins de santé et ont la responsabilité de veiller à ce que les personnes intersexuées se sentent prises en compte, écoutées et soutenues dans leur parcours vers l'obtention d'un soutien, de services et de soins optimaux en matière de santé et de bien-être.



Comment Utiliser Cette Boîte à Outils

Cette boîte à outils est conçue comme une ressource pratique pour soutenir l'intégration des perspectives intersexuées dans les politiques et les pratiques de santé au Nigeria. Elle rassemble les normes en matière de droits humains, l'éthique médicale, les orientations politiques et les expériences vécues afin d'aider les différentes parties prenantes à renforcer les systèmes de santé inclusifs. Les lecteurs sont encouragés à se concentrer sur les sections les plus pertinentes pour leur rôle, tout en reconnaissant que tout changement durable nécessite une collaboration entre les différents secteurs.

Qui Devrait Utiliser Cette Boîte à Outils

Les institutions gouvernementales et les décideurs politiques peuvent utiliser cette boîte à outils pour éclairer l'élaboration des politiques, la réforme juridique et la conception de systèmes de santé inclusifs qui respectent l'autonomie corporelle et les droits humains. Les sections consacrées aux cadres juridiques, à la conception des politiques, à l'engagement des parties prenantes et aux recommandations à l'intention des agences gouvernementales fournissent des orientations pour intégrer l'inclusion des personnes intersexuées dans les stratégies nationales de santé.

Les prestataires de soins de santé et les enseignants en médecine peuvent utiliser cette boîte à outils pour améliorer leur compréhension des réalités intersexuées et renforcer des soins éthiques, respectueux et valorisants. Les sections consacrées à l'éthique médicale, au consentement éclairé, à la santé mentale, aux services de santé inclusifs et aux lignes directrices à l'intention des prestataires de soins de santé proposent des mesures pratiques pour dispenser des soins centrés sur le patient.

Les organisations de la société civile (OSC) et les défenseurs des droits peuvent utiliser cette boîte à outils comme ressource de plaidoyer et de sensibilisation. Elle aide les organisations à renforcer l'engagement communautaire, à développer des initiatives de formation et à collaborer avec les décideurs politiques et les établissements de santé afin de faire progresser l'inclusion des personnes intersexuées.

Comment Naviguer Dans La Boîte à Outils

Cette boîte à outils est structurée de manière à passer des connaissances fondamentales à l'action pratique:

- **Comprendre les réalités intersexuées:** présente les concepts essentiels, les mythes et les faits, ainsi qu'un aperçu des questions relatives aux droits humains qui touchent les personnes intersexuées.
- **Contexte juridique et politique:** présente les normes internationales en matière de droits humains et le paysage juridique nigérian pertinent pour l'inclusion des personnes intersexuées.
- **Élaboration de politiques inclusives:** propose des principes, des stratégies d'engagement des parties prenantes et des mesures pratiques pour concevoir et mettre en oeuvre des politiques de santé inclusives pour les personnes intersexuées.
- **Conseils pratiques et recommandations:** comprend des lignes directrices concrètes pour les prestataires de soins de santé, des recommandations pour les agences gouvernementales et des appels à l'action pour les OSC.

Les lecteurs peuvent choisir de suivre le guide de manière séquentielle ou de se concentrer sur des sections spécifiques en fonction de leurs besoins et de leurs responsabilités.

Utilisation de la Boîte à Outils Pour la Formation et la Mise en Oeuvre

Cette boîte à outils peut être utilisée de plusieurs façons:

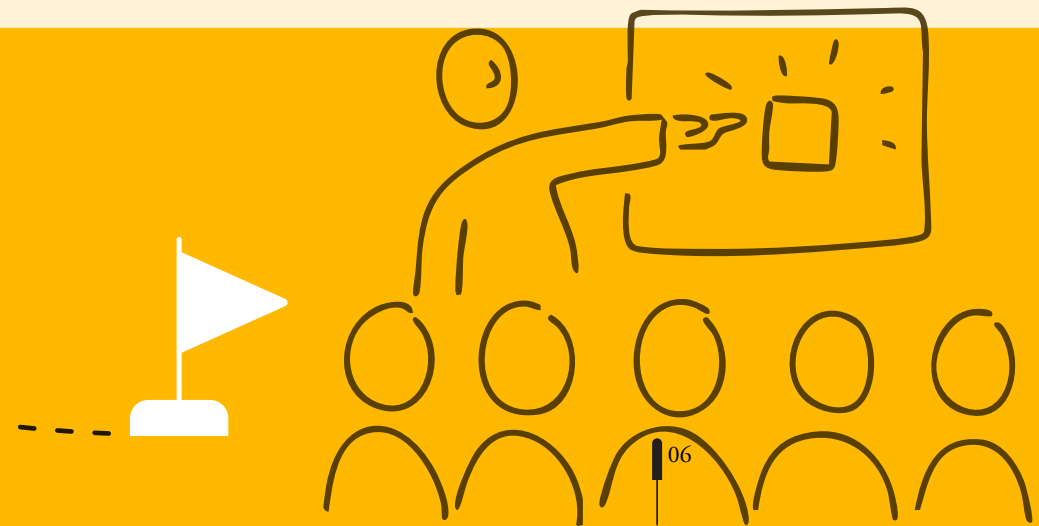
- Comme **ressource de formation** pour les professionnels de santé, les décideurs politiques et les défenseurs.
- Comme r**éférence politique** pour l'élaboration de lignes directrices, de protocoles et de législations inclusifs.
- Comme **outil de plaidoyer** pour promouvoir la sensibilisation, la collaboration et le changement systémique.
- Comme **cadre de dialogue** entre les communautés intersexuées, les établissements de santé et les organismes gouvernementaux.

Principes d'Utilisation de Cette Boîte à Outils

Lorsqu'ils utilisent cette boîte à outils, les lecteurs sont encouragés à:

- De mettre l'accent sur les voix et les expériences vécues des personnes intersexuées.
- De respecter les principes des droits humains, notamment la dignité, l'autonomie corporelle et la non-discrimination.
- Promouvoir la participation significative des communautés intersexuées aux processus décisionnels.
- D'adapter les recommandations au contexte local tout en respectant les normes internationales en matière de droits humains.

En appliquant les connaissances et les conseils contenus dans cette boîte à outils, les parties prenantes peuvent contribuer à la mise en place d'un système de santé au Nigeria qui soit inclusif, respectueux et adapté aux réalités diverses des personnes intersexuées.



SECTION 2 — Comprendre les Réalités Intersexuées

Comprendre l'Intersexualité

Le terme « intersexualité » désigne les personnes nées avec une anatomie reproductive ou sexuelle innée qui ne correspond pas à ce qui est généralement considéré comme un corps « féminin » ou « masculin ». En fait, l'intersexualité est une variation corporelle tout à fait naturelle chez les êtres humains qui, dans certains cas, peut même ne pas être visible à la naissance, mais apparaître à la puberté ou même à l'âge adulte. Une personne peut découvrir qu'elle a un corps intersexué à un très jeune âge ou plus tard dans sa vie. Certaines personnes intersexuées ne le découvrent jamais.

Le terme « intersexué » est un terme générique qui désigne l'ensemble des variations des caractéristiques sexuelles qui existent naturellement dans la biologie humaine. Ce terme reconnaît le fait que le sexe est un spectre et qu'il existe des personnes dont les caractéristiques sexuelles diffèrent de celles des hommes et des femmes.

La plupart des caractéristiques sexuelles humaines sont présentes dès la naissance. Cependant, les personnes intersexuées sont souvent victimes de discrimination ou de violence simplement en raison de leurs caractéristiques sexuelles innées. Le fait qu'une personne ait un corps intersexué peut devenir évident à différents moments de sa vie : à la naissance, pendant l'enfance, à la puberté ou même à l'âge adulte. En fonction des circonstances de vie spécifiques et du niveau de tabou existant dans leur communauté, leurs traits physiques intersexués naturels les exposent à un risque de préjudice en raison de la stigmatisation. L'intersexualité est considérée comme un tabou dans de nombreuses régions du monde, en particulier en Afrique. Selon les Nations unies, au moins 1,7 % de la population, soit 131 millions de personnes dans le monde en 2019, sont nées avec des caractéristiques intersexuées. Cela signifie que près d'une personne sur 60 présente une variation des caractéristiques sexuelles et ne correspond pas à la définition médicale et sociale typique de l'homme ou de la femme, ce qui l'expose à un risque de discrimination et d'autres violations des droits humains à tout âge.[1]

Il existe une grande variété de différences entre les variations intersexuées, notamment des différences au niveau des organes génitaux, des chromosomes, des gonades, des organes reproducteurs internes, de la production et de la réponse hormonales et/ou des caractéristiques sexuelles secondaires (telles que la pilosité corporelle).

Selon des études publiées aux Pays-Bas en 2014, au moins une personne sur 200 risque de subir des interventions chirurgicales invasives et d'autres interventions médicales, telles que des traitements hormonaux, si les professionnels de la santé diagnostiquent un « trouble du développement sexuel » (DSD) ou un diagnostic « non spécifié », tel qu'une « malformation non spécifiée des organes génitaux masculins/féminins ». Bon nombre de ces interventions, en particulier les chirurgies, sont irréversibles, différées, non urgentes et pratiquées sur des corps sains. Elles sont souvent réalisées pendant la petite enfance et l'enfance sans consentement personnel ou pleinement éclairé.[2]

[1] Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. (2019). Note d'information sur les violations des droits humains à l'encontre des personnes intersexuées. https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/background-note-human-rights-violations-against-intersex-peoplehttps://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/background-note-human-rights-violations-against-intersex-people

[2] Carpenter, M. (2016). Les droits humains des personnes intersexuées : lutter contre les pratiques néfastes et le discours du changement. Reproductive Health Matters, 24(47), 74–84. https://doi.org/10.1016/j.rhm.2016.04.003

Le terme « trouble du développement sexuel » (TDS) *est un terme médical générique qui a été introduit en 2006 par une déclaration consensuelle de cliniciens.*[3] *Associé à de nouvelles catégories de « syndromes », il a remplacé les anciens termes médicaux. Certains cliniciens utilisent le terme DSD pour désigner les « différences » ou la « diversité » du développement sexuel. Cependant, sous toutes ses formes, ce terme pathologise les variations saines des caractéristiques sexuelles et désigne les caractéristiques sexuelles intersexuées comme des caractéristiques « déviantes » parrapport à la norme des corps masculins et féminins, qui doivent donc être « clarifiées » ou « corrigées ». Le terme « DSD » n'est pas conforme aux normes en matière de droits humains et n'est utilisé dans le présent document et l'annexe qui l'accompagne que dans des citations directes ou pour faire référence à des concepts médicaux qui utilisent ce terme.*

Les corps intersexués sont souvent perçus comme n'étant ni masculins ni féminins, et de nombreux membres de la société souhaitent « corriger » des corps par ailleurs sains afin qu'ils correspondent à une conception binaire du sexe et du genre. En conséquence, les personnes intersexuées sont exposées à la stigmatisation, à la violence et à des pratiques néfastes, telles que des interventions médicales forcées ou coercitives visant à rendre leur corps plus typiquement féminin ou masculin.

Mythes Courants sur l'Intersexualité et Faits Réels

Mythe: tout le monde naît avec un corps masculin ou féminin

Réalité: Les gens supposent souvent que le monde est divisé en deux groupes distincts, les hommes et les femmes, et que les caractéristiques biologiques et génétiques de chacun correspondent à l'une de ces deux catégories. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il existe des millions de personnes dans le monde qui ont des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux notions binaires typiques des corps masculins ou féminins.

Mythe: L'intersexualité est extrêmement rare.

Réalité: Le consensus scientifique est qu'entre 1.5 et 2% des personnes sont intersexuées.[4] En réalité, l'intersexualité n'est pas si rare, et étant donné que de nombreuses personnes peuvent ne pas avoir facilement détecté leurs caractéristiques intersexuées, ce chiffre pourrait être bien plus élevé. Certaines personnes ne naissent pas avec des caractéristiques intersexuées évidentes, celles-ci pouvant apparaître à la puberté ou plus tard dans la vie, tandis que d'autres peuvent ne jamais les découvrir.

Mythe: L'intersexualité est une condition médicale ou une malformation congénitale qui doit être « corrigée ».

Réalité: depuis les années 1950, et après que les travaux du scientifique John Money, aujourd'hui discrédité, aient eu un impact en Europe et en Amérique du Nord, les opérations visant à « corriger » les personnes intersexuées sont devenues pluscourantes et se sont exportées dans le monde entier. Les personnes intersexuées sont rarement gênées par leurs variations corporelles naturelles et, le plus souvent, le « traitement » cause des dommages physiques et émotionnels à vie. Il n'est en aucun cas nécessaire de « corriger » une personne intersexuée, et le mythe qui soutient cette idée est particulièrement préjudiciable à la communauté intersexuée.[5]

[3] Hughes IA, Houk C, Ahmed SF, Lee PA; LWPES Consensus Group; ESPE Consensus Group. Consensus statement on management of intersex disorders. Arch Dis Child. 2006 Jul;91(7):554-63. doi: 10.1136/adc.2006.098319. Epub 2006 Apr 19. PMID: 16624884; PMCID: PMC2082839.Hughes IA, Houk C, Ahmed SF, Lee PA ; LWPES Consensus Group ; ESPE Consensus Group. Déclaration consensuelle sur la prise en charge des troubles intersexués. Arch Dis Child. Juillet 2006 ; 91(7) : 554-63. doi : 10.1136/adc.2006.098319. Publication électronique 19 avril 2006. PMID : 16624884 ; PMCID : PMC2082839.

[4] https://ihra.org.au/16601/intersex-numbers/

[5] Amnesty International. (2017). D'abord, ne pas nuire : garantir les droits des enfants présentant des variations des caractéristiques sexuelles au Danemark et en Allemagne (Index n° EUR 01/6086/2017). https://www.amnesty.org/en/documents/eur01/6086/2017/en/

Mythe: les personnes intersexuées ont « les deux » organes génitaux ou sont « des deux » sexes.

Réalité: Fact: En vérité, c'est plus compliqué que cela. Le sexe est une série de caractéristiques et de spectres, et le corps humain peut se développer de nombreuses façons. Avoir à la fois un pénis et un vagin n'en fait pas partie. Les médias, en particulier, ont tendance à présenter les personnes intersexuées comme « nées avec les deux organes », ce qui est faux et ne fait que perpétuer des stigmates et des stéréotypes néfastes.

Mythe: Toutes les personnes intersexuées ont des organes génitaux ambigus à la naissance et ont subi des interventions chirurgicales.

Réalité: Toutes les personnes intersexuées n'ont pas des organes génitaux ambigus à la naissance, toutes les expériences intersexuées n'impliquent pas une intervention chirurgicale, et tous les préjudices médicaux intersexués ne sont pas chirurgicaux, mais peuvent prendre d'autres formes, telles que des pratiques médicales néfastes, l'administration **non consensuelle ou forcée d'hormones** pour « normaliser » les niveaux ou induire/arrêter la puberté sans informations complètes et adaptées à l'âge ou sans alternatives. Dilatation vaginale forcée ou sous pression chez les jeunes. Photographie médicale non consentie. Refus ou retard de soins médicaux nécessaires en raison de préjugés ou de confusion. Exposition prénatale à des médicaments destinés à « prévenir » les traits intersexués, par exemple des stéroïdes pour l'hyperplasie congénitale des surrénales (HCS) sans consentement éclairé. Communication du diagnostic à l'école, à l'employeur ou à la famille sans autorisation.

Mythe: les personnes intersexuées sont transgenres.

Réalité: Le mot « transgenre » ou « trans » est un terme générique qui désigne les personnes dont l'identité de genre est différente du sexe qui leur a été attribué à la naissance. Le mot « intersexué » fait référence à des variations physiques innées descaractéristiques sexuelles, et non à un sentiment d'identité interne. Il est donc faux de dire que toutes les personnes intersexuées (ou même la plupart d'entre elles) sont transgenres.

Mythe: L'intersexualité est un tabou ou un mauvais présage.

Réalité: L'intersexualité est une diversité biologique et innée des caractéristiques sexuelles humaines et n'est pas un tabou. La perception culturelle erronée selon laquelle les personnes intersexuées sont en quelque sorte mauvaises ou portent malheur est un malentendu extrêmement préjudiciable qui entraîne une stigmatisation douloureuse et des préjudices tant pour les personnes intersexuées que pour leur famille.

Mythe: Les personnes intersexuées ne peuvent pas avoir de relations sexuelles, tomber enceintes ou avoir des enfants.

Réalité: de nombreuses variations intersexuées comprennent une anatomie reproductive interne essentiellement typique. Chaque personne est différente. Certaines personnes intersexuées peuvent avoir leurs règles et porter des enfants, d'autres peuvent produire du sperme. Certaines ne peuvent ni porter d'enfants ni produire de sperme.



Intersexualité et Genre

L'intersexualité est une caractéristique sexuelle, tout comme le fait d'être une femme ou un homme, ce n'est pas une identité de genre. L'intersexualité et l'identité de genre sont des sujets complexes et intéressants qui se recoupent de nombreuses façons. Ces recoupements découlent du fait que les personnes intersexuées sont confrontées à une multitude de défis pour comprendre et naviguer dans leur propre identité de genre. En raison de la stigmatisation dont sont victimes les personnes intersexuées et leur corps, beaucoup peuvent s'identifier au sexe qui leur a été attribué à la naissance sur la base des caractéristiques sexuelles internes et physiques prédominantes à la naissance. Pour les personnes intersexuées, le sexe biologique attribué n'est pas le seul déterminant de leur identité de genre ; une multitude de facteurs liés à la maturation de leur corps peuvent modifier l'apparence de leurs caractéristiques sexuelles internes et/ou physiques, les faisant passer du sexe attribué à la naissance à un sexe opposé.



Les personnes intersexuées proviennent de tous les milieux socio-économiques, cultures, races, ethnies, confessions et idéologies politiques. L'intersexualité n'est pas en soi une orientation sexuelle ni même une identité de genre. Bien que certaines personnes présentant des caractéristiques intersexuées s'identifient comme « intersexuées », la majorité d'entre elles ne le font pas et s'identifient plutôt comme hommes ou femmes. Les personnes intersexuées peuvent également s'identifier à une identité de genre non binaire. L'intersexualité n'est pas la même chose que la transidentité. Cependant, comme les personnes transgenres, certaines personnes intersexuées grandissent en s'identifiant à un genre différent de celui qui leur a été attribué à la naissance, le plus souvent en raison de changements qui surviennent dans l'anatomie de leur corps au cours du développement des caractéristiques sexuelles.

La plupart des sociétés sont structurées selon la binarité supposée des sexes. Ces systèmes sociétaux rendent les personnes qui ne correspondent pas à la binarité masculine-féminine particulièrement vulnérables aux violations de l'intégrité physique, à la discrimination, au harcèlement, à la violence dans les milieux médicaux et au harcèlement à l'école et au travail. Les violations des droits humains auxquelles sont confrontées les personnes intersexuées trouvent leur origine dans ce que le bioéthicien George Annas a appelé « l'éthique du monstre », comme le souligne un article critique sur la chirurgie publié dans le Journal of Pediatric Urology en 2016.[6] « *Les bébés de sexe atypique ne sont pas encore [considérés] comme pleinement humains et n'ont donc pas droit aux droits humains. Les chirurgiens les rendent humains en les rendant reconnaissables comme hommes ou femmes, et ce n'est qu'alors qu'ils peuvent être considérés comme ayant droit aux droits et protections sexuels et médicaux garantis à tous les autres par les directives éthiques et les lois en vigueur.* »[7]

[6] Journal of Pediatric Urology, ISSN : 1477-5131, vol. 12, n° 6, p. 436-437, 2016.
[7] Ehrenreich, N., & Barr, M. (2016). Chirurgie intersexuée, mutilations génitales féminines et condamnation sélective des pratiques « culturelles ». Journal of Pediatric Urology, 12(6), 404–409. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2016.08.013

Aperçu des Principales Questions Relatives à l'Intersexualité

Droits Humains: Inclusion des Personnes Intersexuées et Protection Contre les Pratiques Néfastes

Les droits humains sont universels et indivisibles, ce qui signifie qu'ils s'appliquent à tous, y compris aux personnes intersexuées. La Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) stipule que tout être humain, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, naît libre et égal en dignité et en droits.[8] Bien qu'aucune disposition spécifique ne fasse actuellement référence aux personnes intersexuées, les droits contenus dans les traités internationaux relatifs aux droits humains s'appliquent à tous, y compris aux personnes intersexuées, grâce aux clauses non discriminatoires ouvertes des conventions.

Lorsqu'un nouveau-né arrive, les gens demandent toujours immédiatement: « C'est un garçon ou une fille? ». À première vue, cette question apparemment innocente révèle la nature profondément ancrée des rôles sexuels et de genre dans notre société, ainsi que la classification binaire des sexes. De plus, le fait qu'il n'existe aucune comparaison naturelle à la ligne rigide que nous utilisons pour diviser les hommes et les femmes en deux groupes qui ne peuvent se mélanger démontre à quel point nous comprenons peu le sexe et ses classifications.

Après la naissance, les personnes intersexuées, qu'elles soient enfants, adolescentes ou adultes, sont confrontées à des violations courantes de leur intégrité physique, notamment des interventions médicales sans consentement personnel, préalable, persistant et pleinement éclairé. L'un des plus grands problèmes auxquels est confrontée la communauté intersexuée est celui des opérations chirurgicales non consenties pratiquées sur les enfants intersexués. Il s'agit d'interventions non vitales visant à modifier l'apparence des organes génitaux et l'anatomie reproductive afin de les adapter à des normes arbitraires. Les pratiques non consenties et médicalement inutiles, telles que les mutilations génitales et l'infanticide, soumettent constamment les enfants intersexués à des violations de leurs droits au consentement pleinement éclairé, à l'autonomie corporelle et à l'autodétermination. Dans la plupart des cas, cela provoque des traumatismes psychologiques ainsi que de graves handicaps physiques, allant de la stérilité, des tissus cicatriciels douloureux ou un manque de sensation à l'ostéoporose et des problèmes urétraux.

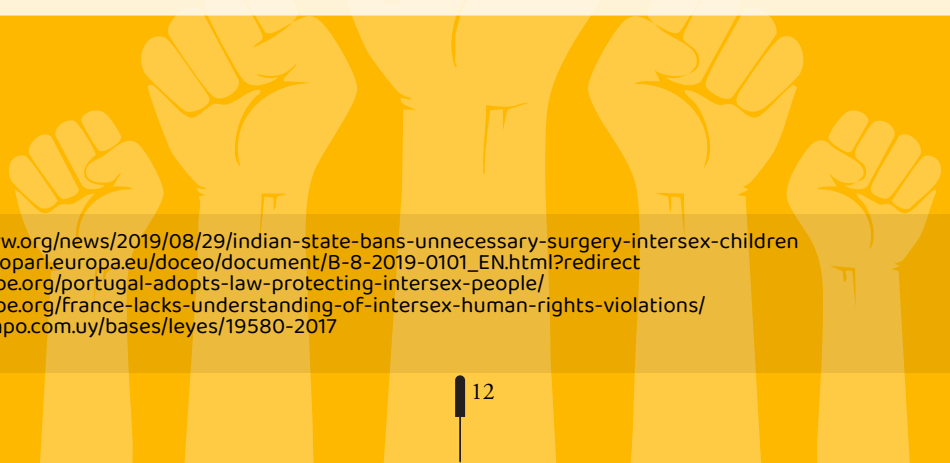
Les enfants intersexués courent le risque de voir leur vie familiale perturbée en raison des tabous culturels et de la médicalisation. Ils courent également un risque élevé d'abandonner l'école en raison des effets de ces traitements médicaux et duharcèlement dont ils sont victimes en raison de leurs différences physiques.[9] Les adultes intersexués ont généralement des difficultés à trouver un emploi en raison d'un manque d'éducation, de handicaps physiques ou d'un manque d'estime de soi causé par la stigmatisation sociale.

[8] Nations Unies. (1948). Déclaration universelle des droits de l'homme. (Nations Unies, 1948, art. 1-2)
[9] SIPD Uganda, "Baseline survey on intersex realities in East Africa" (2017).SIPD Ouganda, « Enquête de référence sur les réalités intersexuées en Afrique de l'Est » (2017).

Les personnes intersexuées seraient exposées à un risque plus élevé de pauvreté en raison d'un manque d'éducation résultant de la pathologisation et des traumatismes qui y sont associés. À tout âge, au Nigeria, les personnes intersexuées sont confrontées à la stigmatisation, à la discrimination structurelle et verbale, au harcèlement, à un manque de soins médicaux adéquats, à un manque d'accès aux médicaments nécessaires, à un manque de reconnaissance juridique et à l'invisibilité de leur corps.

Les personnes intersexuées sont vulnérables à la discrimination et aux abus dans tous les domaines de la vie. Leur invisibilité, leur exclusion et le manque général de connaissances sur les questions intersexuées dans la société alimentent la discrimination, la stigmatisation et la pathologisation en toute impunité, en particulier en l'absence de lois et de politiques non discriminatoires spécifiques aux personnes intersexuées. Au Nigeria, l'intersexualité est considérée comme un tabou, un mauvais présage et une malédiction générationnelle infligée par Dieu comme une forme de punition. En conséquence, les personnes qui s'identifient ouvertement comme intersexuées sont confrontées à de nombreuses pratiques discriminatoires. Les auteurs de ces actes discriminatoires se basent généralement sur ce qu'ils perçoivent comme une non-conformité de genre de la part des personnes intersexuées, dans leur comportement, leur apparence ou les deux.

Certains pays prennent des mesures pour mettre fin aux chirurgies intersexuées sur les nourrissons et promouvoir les droits des personnes intersexuées. Par exemple, Malte, le Kenya, la Colombie, l'Espagne, l'Afrique du Sud, l'Islande, la Grèce, l'Allemagne, le Pakistan, un territoire australien et l'État indien du Tamil Nadu1[10] ont légiféré pour protéger les personnes intersexuées, tandis que d'autres ont explicitement interdit les chirurgies intersexuées sans le consentement éclairé de la personne concernée. En 2019, le Parlement européen a adopté une résolution[11] appelant tous les États membres à mettre fin à ces chirurgies. Le Portugal[12], la France[13], et l'Uruguay[14] ont chacun adopté des lois visant à protéger les personnes intersexuées, mais celles-ci pourraient ne pas suffire à mettre fin aux chirurgies non consenties. En 2018, la Haute Cour du Kenya a ordonné au gouvernement de reconnaître officiellement les personnes intersexuées dans les documents officiels, tels que les actes de naissance. Cette décision a constitué une avancée significative vers la reconnaissance juridique et la protection des personnes intersexuées.



[10] https://www.hrw.org/news/2019/08/29/indian-state-bans-unnecessary-surgery-intersex-children
[11] http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0101_EN.html?redirect
[12] https://oiieurope.org/portugal-adopts-law-protecting-intersex-people/
[13] https://oiieurope.org/france-lacks-understanding-of-intersex-human-rights-violations/
[14] https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19580-2017

Cadres Juridiques et Éthiques

Les normes internationales en matière de droits humains pour les personnes intersexuées constituent un cadre essentiel pour la protection et la promotion des droits et du bien-être de cette minorité marginalisée. En vertu de la législation internationale relative aux droits humains, les droits des personnes intersexuées reposent sur des concepts tels que l'égalité, la non-discrimination, l'autonomie physique et le droit à la santé.[15,16] La Déclaration universelle des droits de l'homme et les traités qui ont suivi, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques[17] et la Convention relative aux droits de l'enfant,[18] contiennent des dispositions qui s'appliquent à la protection des droits des personnes intersexuées.

Ces instruments condamnent spécifiquement la discrimination sexuelle et d'autres formes de discrimination, promeuvent le droit à la vie privée et défendent le droit à l'intégrité physique et mentale. En outre, ils reconnaissent que chaque enfant a droit à la meilleure santé possible et soulignent l'importance du consentement éclairé pour les procédures médicales.

Les déclarations, résolutions et recommandations au niveau des Nations unies contribuent à renforcer les normes internationales en matière de droits humains des personnes intersexuées. Ces textes plaident en faveur de l'éradication des pratiques néfastes, telles que les interventions chirurgicales non consenties et médicalement inutiles sur les enfants intersexués, et soulignent l'importance pour les personnes intersexuées de bénéficier d'un soutien, de soins de santé et d'une éducation inclusive. Si des progrès ont été réalisés dans la reconnaissance des droits des personnes intersexuées à travers le monde, il reste encore beaucoup à faire, en particulier au Nigeria. La plupart des personnes intersexuées continuent d'être victimes de stigmatisation, de préjugés et de violence, et leurs voix sont souvent réduites au silence. Les institutions gouvernementales, les prestataires de soins de santé et les organisations de la société civile doivent veiller à ce que les droits humains des personnes intersexuées soient reconnus, protégés et respectés dans tous les aspects de la vie. Cela implique notamment de mettre fin aux pratiques discriminatoires, de garantir l'accès à des soins de santé appropriés et de qualité, et de sensibiliser la société à la diversité intersexuée afin de la faire accepter.

Le respect de cette norme exige également l'abolition de l'attribution légale du genre sans consentement, la promotion de l'autodétermination et la reconnaissance de la diversité des caractéristiques sexuelles. Elle souligne la nécessité pour les personnes intersexuées de participer aux processus décisionnels qui affectent leur vie, leur permettant ainsi d'avoir leur mot à dire dans les politiques et les pratiques.

[15]Le rapport Born Free and Equal (2016) du HCDH qualifie explicitement les personnes intersexuées de « groupe protégé » en vertu des instruments existants.
[16]ICCPR, art. 7 (interdiction de la torture) ; CRC, art. 24 (santé) et art. 3 (intérêt supérieur) ; Convention contre la torture, art. 1-2 ; HCDH (2016), pp. 30-31.
[17]International Covenant on Civil and Political Rights, Dec. 19, 1966, S. Exec. Doc. No. 95-2, 999 U.N.T.S. 171.Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, S. Exec. Doc. n° 95-2, 999 U.N.T.S. 171.
[18]Nations Unies. (1989). Convention relative aux droits de l'enfant, 1577 U.N.T.S. 3.

Conventions, Résolutions et Traités Internationaux Relatifs aux Droits de l'Homme qui Protègent les Droits des Personnes Intersexuées

Le droit international relatif aux droits de l'homme impose des obligations aux États parties. L'obligation de respecter signifie que les États doivent s'abstenir d'interférer avec la jouissance des droits de l'homme ou de la restreindre. L'obligation de protéger exige des États qu'ils protègent les individus et les groupes contre les violations des droits de l'homme. L'obligation de mettre en oeuvre signifie que les États doivent prendre des mesures positives pour faciliter la jouissance des droits fondamentaux.

Les principes des droits de l'homme incluent le fait que les droits de l'homme sont universels et inaliénables, car tout le monde naît avec les mêmes droits et ne peut en être privé. Ils sont indivisibles et interdépendants, car tous les droits ont la même importance et aucun ne peut être pleinement exercé sans les autres. Ils s'appliquent à tous de manière égale, sans discrimination, et tout le monde a le droit de participer et d'être inclus dans les décisions qui affectent sa vie. Ils sont garantis par l'état de droit et les responsables ont le devoir de les respecter.

1. Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH):

Le premier accord international sur les droits de l'homme a été la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH), adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948. La DUDH engage les États à protéger les droits à l'égalité de tous les êtres humains:

L'article 1 stipule que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ».

L'article 2 stipule que « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation », et

L'article 7 stipule en outre que « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans discrimination à une protection égale de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute incitation à une telle discrimination. »D'autres droits fondamentaux énoncés dans la DUDH sont examinés plus en détail ci-dessous.

Les principes fondamentaux énoncés dans la DUDH, tels que l'universalité, l'interdépendance et l'indivisibilité des droits, l'égalité et la non-discrimination, et le fait que les droits de l'homme impliquent à la fois des droits et des obligations pour les responsables et les titulaires de droits, se reflètent dans de nombreuses conventions, déclarations et résolutions internationales relatives aux droits de l'homme qui ont suivi la DUDH.[19]

[19] https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights

2. Convention Relative aux Droits de l'Enfant (CDE):

La CDE, ratifiée par la quasi-totalité des États membres de l'ONU, reconnaît les droits des enfants intersexués.

L'article 3 garantit que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les actions le concernant, y compris les enfants intersexués.

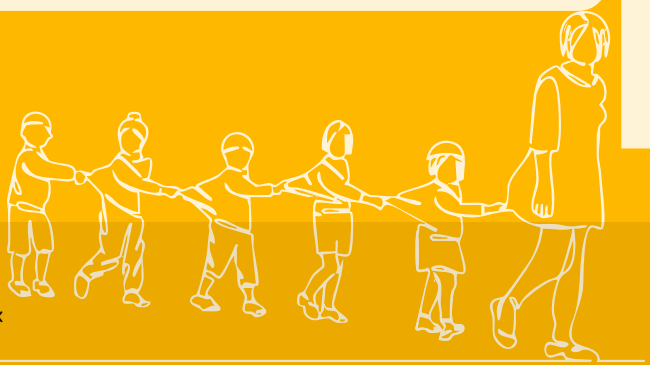
L'article 19 protège les enfants intersexués contre toutes les formes de violence physique et mentale, y compris les interventions médicales non consenties, qui sont parfois pratiquées sans leur consentement éclairé.[20]

3. Convention Contre la Torture et Autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants (CAT):

La CAT, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1984, interdit la torture et autres formes de mauvais traitements. Elle exige explicitement des États qu'ils préviennent et combattent la torture, y compris les interventions médicales sans consentement éclairé, qui peuvent constituer des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les personnes intersexuées soumises à des interventions médicales non consenties peuvent demander réparation en vertu de cette convention.[21]

4. Convention sur l'Élimination de Toutes les Formes de Discrimination à L'égard des Femmes (CEDAW):

La CEDAW, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1979, oblige les États à éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans tous les domaines de la vie. Une approche intersectionnelle a conduit à la reconnaissance du fait que certaines pratiques, telles que les interventions médicales inutiles et non consenties sur les femmes intersexuées, peuvent constituer une discrimination et une violence à l'égard des femmes. La CEDAW souligne l'importance de garantir l'autonomie et l'intégrité corporelles des personnes intersexuées, tout comme elle appelle à la fin des mutilations génitales féminines.[22]



[20] https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
[21] https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx
[22] https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx

5. Principes de Yogyakarta:

Les Principes de Yogyakarta, un ensemble de principes internationaux sur l'application du droit international des droits humains en matière d'orientation sexuelle, d'identité de genre et d'expression de genre, traitent spécifiquement des droits des personnes intersexuées. Ces principes mettent l'accent sur le droit à l'autonomie corporelle, l'interdiction des interventions médicales non consenties, le droit à la reconnaissance du genre et le droit de vivre à l'abri de la violence et de la discrimination.[23]

6. Le Pacte International Relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels (PIDESC)

Le PIDESC, également adopté par l'Assemblée générale en 1966, énonce les droits économiques, sociaux et culturels de toutes les personnes, qui doivent être exercés sans discrimination aucune *« fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation »* (article 2(2)). Ces droits comprennent le droit au travail (article 6) et à des conditions de travail justes et favorables (article 7), le droit à la sécurité sociale (article 9), le droit de toute personne au meilleur état de santé susceptible d'être atteint (article 12) et le droit de toute personne à l'éducation (article 13).

L'article 2(1) du PIDESC stipule que chaque État partie au Pacte « s'engage à prendre des mesures, individuellement et par le biais de l'assistance et de la coopération internationales, notamment économiques et techniques, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives ».[24]

7. Résolution 552 de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP)

La résolution 552, intitulée « Promotion et protection des droits des personnes intersexuées en Afrique », a été adoptée par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) lors de sa 74e session ordinaire, le 7 mars 2023. Cette résolution historique appelle les États africains à mettre fin aux chirurgies de normalisation génitale non consenties et inutiles sur les enfants intersexués, reconnaissant ces pratiques comme des violations des droits humains au même titre que les mutilations génitales. La résolution souligne la nécessité de mettre en place des programmes éducatifs complets afin de protéger les personnes intersexuéescontre la discrimination, l'infanticide, l'abandon et d'autres violations des droits humains.[25]

[23] https://yogyakartaprinciples.org
[24] https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
[25] https://achpr.au.int/en/adopted-resolutions/resolution-promotion-and-protection-rights-intersex-persons

8. Résolution des Nations Unies sur l'Intersexualité

En 2024, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies a adopté sa toute première résolution visant spécifiquement à protéger les droits des personnes intersexuées. Ce document historique, intitulé « Lutter contre la discrimination, la violence et les pratiques néfastes à l'égard des personnes intersexuées », a été présenté par plusieurs pays, dont l'Australie, le Chili, la Finlande et l'Afrique du Sud, et a été adopté à l'unanimité, sans aucune voix contre.[26] La résolution demandait au HCDH des Nations unies de présenter un rapport et d'organiser une table ronde lors de la60esession du CDH. Le rapport formulait un certain nombre de recommandations novatrices, notamment la protection des personnes intersexuées contre la discrimination et la violence dans les établissements médicaux, les écoles, le monde du travail, etc.[27]

Il convient de noter que ces résolutions adoptées à la fois par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies ont considérablement renforcé l'importance, la crédibilité et la sensibilisation aux questions liées à l'intersexualité, ainsi que la nécessité pour les États de protéger et d'inclure les personnes intersexuées.



[26] https://docs.un.org/en/A/HRC/55/L.9
[27] 60e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Lois et politiques discriminatoires, actes de violence et pratiques préjudiciables à l'encontre des personnes intersexuées, Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, 8 août 2025. https://docs.un.org/en/A/HRC/60/50

Le Contexte Juridique Nigérian

Au Nigeria, comme dans de nombreux autres pays africains, les personnes intersexuées sont victimes de stigmatisation, de discrimination, de procédures médicales forcées sans consentement éclairé et adéquat, ainsi que d'une « invisibilité » plus générale dans la législation, la réglementation et les politiques, ce qui a un impact sur leur accès aux services et leurs droits à la santé, au bien-être et au développement.

Au Nigeria, il n'existe aucune loi protégeant spécifiquement les droits des personnes intersexuées. Les lois nigérianes actuelles sont principalement basées sur le modèlebinaire des sexes, qui ne tient pas compte des besoins et des expériences spécifiques des personnes intersexuées. Par exemple, la loi de 2015 sur l'interdiction de la violence à l'égard des personnes (VAPP) vise à éradiquer la violence dans les sphères privée et publique, en interdisant toutes les formes de violence à l'égard des personnes, en particulier les femmes et les filles, qui en souffrent de manière disproportionnée. Elle offre une protection maximale et des recours efficaces aux victimes, tandis que la loi sur les droits de l'enfant (CRA) protège les droits de tous les enfants au Nigeria. Bien que nous puissions utiliser ces lois pour défendre les droits des enfants et des adultes intersexués, leurs nombreuses lacunes et nuances pourraient limiter nos efforts de plaidoyer.[28]

La Constitution de 1999 de la République fédérale du Nigeria stipule que toute personne a le droit de ne pas être traitée de manière injuste ou discriminatoire en raison de son genre et de son sexe, mais elle ne protège pas explicitement les personnes intersexuées.[29] Il n'existe pas non plus de lois réglementant directement les procédures et interventions médicales souvent pratiquées sur les personnes intersexuées sans leur consentement pleinement éclairé, telles que les chirurgies non consenties ou les traitements hormonaux. En raison du manque de précision de la loi, l'autonomie corporelle et les droits des personnes intersexuées continuent d'être bafoués.

La société nigériane a actuellement une connaissance et une compréhension limitées des questions liées à l'intersexualité, ce qui rend difficile pour les personnes intersexuées de s'entendre avec les autres et d'éviter d'être victimes de discrimination, en particulier dans les établissements de santé où les corps intersexués sont constamment pathologisés. Comme les Nigérians intersexués ne bénéficient d'aucune protection juridique, leurs problèmes s'aggravent et ils sont plus susceptibles de voir leurs droits humains violés, par exemple en étant contraints de subir une intervention chirurgicale, en ne recevant pas de soins médicaux et en se voyant refuser un emploi ou une éducation.

Afin d'améliorer le système juridique, le gouvernement nigérian devrait mettre à jour les lois et politiques existantes en adoptant une législation complète qui reconnaisse et protège explicitement les droits et les expériences des personnes intersexuées. Cette législation devrait aborder des questions telles que les interventions médicales non consenties, la discrimination et le droit à l'autonomie corporelle. Elle devrait prévoir des campagnes de sensibilisation et d'éducation du public, et veiller à ce que chacun ait accès à des soins médicaux appropriés, à un soutien émotionnel et social, et à la reconnaissance officielle de son identité de genre et de son sexe, quelles que soient ses caractéristiques sexuelles.

[28] https://fida.org.ng/wp-content/uploads/2020/09/Violence-Against-Persons-Prohibition-Act-2015-1.pdf
[29] https://nigeriarights.gov.ng/files/constitution.pdf

Services de Santé Inclusifs

Le système de santé nigérian n'est pas équipé pour fournir des services inclusifs et valorisants aux personnes intersexuées. En fait, les personnes intersexuées ont fait état d'expériences de insensibilité, de manque de respect et d'absence de services conviviaux et non discriminatoires adaptés à leurs besoins spécifiques de la part des prestataires de soins de santé. Les services de santé inclusifs pour les personnes intersexuées sont pratiquement inexistants au Nigeria en raison des tabous culturels et sociaux de longue date qui entourent les personnes intersexuées et leurs familles. Le manque de sensibilisation et de compréhension de leurs besoins et obstacles en matière de santé conduit à des erreurs fréquentes de diagnostic des corps intersexués, à des « traitements » forcés et non consentis, et à un manque de respect général pour leur bien-être physique et psychologique. Ce manque s'accompagne de préjugés personnels qui se traduisent également par de l'incrédulité et des insultes, le refus d'effectuer les examens nécessaires, et des examens réalisés de manière violente ou sans le consentement de la personne intersexuée. Des cas ont été signalés où les organes génitaux d'une personne intersexuée ont été exposés lors d'un examen médical et où le médecin est sorti pour faire entrer ses étudiants en médecine (sans consentement) afin d'utiliser le corps intersexué à des fins pédagogiques. Les personnes concernées ont expliqué que leurs organes génitaux étaient constamment manipulés sans leur consentement et que les étudiants faisaient des commentaires déplacés pendant ce temps.

Depuis des années, les personnes intersexuées sont victimes de stigmatisation, de discrimination et de traumatismes répétés de la part des prestataires de soins de santé lorsqu'elles ont recours aux services de santé dans le cadre du système desanté. Les préjugés et les idées fausses qui prévalent dans la société à l'égard des personnes intersexuées font souvent l'objet de jugements, de moqueries et de mauvais traitements de la part des prestataires de soins de santé. Elles sont constamment victimes d'abus, de mauvais traitements et d'insultes, certains faisant des commentaires très déplacés, allant jusqu'à leur refuser carrément des services ou à refuser de répondre à leurs besoins médicaux. Dans d'autres cas, l'idée binaire de l'existence de corps masculins ou féminins crée une perception qui surprend les prestataires de soins de santé lorsqu'ils voient une personne intersexuée se présenter dans leurs établissements pour obtenir des soins. Au lieu de communiquer honnêtement leur incertitude quant à la manière de répondre à leurs besoins spécifiques, ils deviennent plutôt rancuniers et hostiles.

L'absence de lois, de directives ou de protocoles spécifiques a exacerbé le manque de sensibilisation et de compréhension parmi les professionnels de santé et s'est infiltrée dans le système de santé. Au Nigeria, il n'existe aucune procédure ou politique standard mise en place par l'Association médicale nigériane ou le gouvernement pour garantir que les personnes intersexuées bénéficient de services inclusifs, diversifiés, appropriés et dignes, ainsi que de soins valorisants. C'est l'un des facteurs qui alimentent la discrimination, l'indifférence et les attitudes et traitements condescendants auxquels sont confrontées les personnes intersexuées et leurs familles lorsqu'elles tentent d'accéder aux services de santé au Nigeria.

Par exemple, un participant a mentionné lors de notre discussion de groupe qu'il s'était rendu dans un hôpital privé à Abuja pour une endométriose nécessitant la suppression de ses hormones primaires, mais que selon les médecins, en raison de ses caractéristiques intersexuées, ils voulaient au contraire augmenter les hormones qui affectaient son corps, car ils craignaient de le féminiser, lui et ses organes, car il avait été assigné femme à la naissance et que son identité de genre ne correspondait pas à cela. L'un des médecins lui a prescrit des médicaments sans l'informer des effets secondaires, mais l'a plutôt contraint à les prendre rapidement afin qu'ils agissent immédiatement. Plus tard, en rentrant chez lui, il a fait des recherches sur Google au sujet de ces médicaments et a découvert que l'un des effets secondaires était une augmentation du volume des seins, ce qui n'était pas ce qu'il souhaitait.

Cela va plus loin et montre que pour les problèmes de santé qui ne sont pas liés à leur variation des caractéristiques sexuelles, les personnes intersexuées sont confrontées à des difficultés auxquelles la population endosexuée (non intersexuée) n'est pas confrontée dans les établissements de santé lorsqu'elles accèdent aux soins. Une étude britannique réalisée en 2018 a révélé que les personnes intersexuées interrogées étaient plus susceptibles que les personnes non intersexuées de déclarer que leur médecin généraliste ne les soutenait pas. Les personnes intersexuées interrogées étaient également plus susceptibles que les personnes non intersexuées de déclarer qu'elles étaient trop inquiètes, anxieuses ou gênées pour consulter leur médecin généraliste[30]

Des politiques de santé inclusives sont essentielles pour garantir le bien-être et les droits de tous les individus. Les personnes intersexuées sont confrontées à des défis uniques lorsqu'il s'agit d'accéder aux soins de santé au Nigeria. Elles sont victimes de discrimination et de soins médicaux inadéquats tout au long de leur vie. Il est important de veiller à ce que les politiques et les pratiques en matière de soins de santé au Nigeria soient inclusives et sensibles aux besoins des personnes intersexuées. Cela nécessite la création de lignes directrices informées sur l'intersexualité à l'intention des prestataires de soins de santé sur la manière de fournir des soins respectueux et valorisants aux patients intersexués, de garantir l'accès à des interventions médicales appropriées en cas de besoin et de protéger les personnes intersexuées contre les pratiques néfastes telles que les chirurgies non consenties ou les interventions médicales inutiles.

En outre, des campagnes d'éducation et de sensibilisation du public sont nécessaires pour dissiper les mythes et les idées fausses qui entourent la réalité des personnes intersexuées au Nigeria. Ces campagnes devraient viser à promouvoir une société plus compatissante et plus compréhensive, dans laquelle les personnes intersexuées sont respectées et protégées. Il est impératif d'impliquer les parties prenantes telles que les prestataires de soins de santé, les décideurs politiques et les organisations de la société civile afin de collaborer et d'élaborer des lignes directrices et des politiques globales qui répondent aux besoins spécifiques des personnes intersexuées en matière de soins de santé.

[30] https://www.gov.uk/government/publications/variations-in-sex-characteristics-technical-paper

Santé Mentale et Bien-être

Les personnes nées intersexuées sont souvent confrontées à de nombreux défis psychosociaux dans leur vie et leurs relations avec les autres au sein de sociétés qui privilégient une conception binaire du sexe et du genre. L'impact psychologique et social de l'intersexualité au Nigeria est profond ; il contribue à façonner la perceptionque l'on a de soi-même, la capacité à nouer et à entretenir des relations, ainsi que le bien-être général. Les personnes intersexuées au Nigeria sont constamment en proie à des sentiments de confusion, de mauvaise image corporelle, de honte et d'isolement, car elles ont du mal à comprendre leur propre corps.

L'exclusion constante du corps intersexué dans la culture nigériane, qui s'inscrit dans la notion binaire des corps masculins et féminins, provoque un sentiment de différence ou d'anormalité, qui entraîne souvent une image négative de soi et une faible estime de soi chez les personnes intersexuées. De nombreuses personnes intersexuées ont déclaré souffrir d'anxiété et de dépression après avoir subi des interventions médicales néfastes, telles que des opérations chirurgicales inutiles, sans leur consentement personnel, préalable et pleinement éclairé.



Une personne intersexuée a partagé son expérience personnelle lors du groupe de discussion, que nous appellerons Grace.

« Je m'appelle Grace, je suis une personne intersexuée de 26 ans et je vis dans l'État d'Enugu. Honnêtement, je ne vais plus à l'hôpital à cause des expériences que j'ai vécues. Au cours des 12 dernières années, chaque fois que je me rendais à l'hôpital, je regrettais toujours d'y être allée et que ma mère m'y ait toujours emmenée. La dernière expérience qui m'a poussée à ne plus y retourner tant que je n'aurais pas gagné suffisamment d'argent pour me payer un hôpital privé, c'est lorsque j'ai dit au médecin que l'opération que j'avais subie à l'âge de 16 ans avait provoqué un gonflement autour de la zone opérée, et que je voulais qu'il l'examine et me dise ce qu'il en était. Après m'avoir examiné et m'avoir posé des questions qui, selon moi, n'avaient aucun rapport avec la situation, il m'a dit qu'il allait me donner quelque chose pour réduire le gonflement et me prescrire des médicaments. Il m'a injecté une substance qui m'a fait me réveiller deux jours plus tard pour découvrir que j'avais été opéré sans mon consentement. C'était le médecin qui m'avait opéré des années auparavant et qui essayait de corriger l'erreur qu'il avait commise à l'époque, avec l'accord de mon frère, mais sans mon consentement. Quelques jours plus tard, j'ai été autorisée à sortir de l'hôpital et je suis rentrée chez moi avec le sentiment de ne plus avoir aucun contrôle ni aucun pouvoir sur ma vie et mon corps, me demandant sans cesse à Dieu pourquoi j'avais été créée ainsi et combien de temps encore je serais utilisée par ces médecins pour leurs tentatives infructueuses de corriger mon corps. Pendant trois mois, j'ai lutté contre la dépression et je suis restée cloîtrée chez moi. Après cela, j'ai quitté la maison et je n'y suis pas retournée depuis trois ans.

Une autre pratique courante qui a nui à la santé mentale des personnes intersexuées et au bien-être de leurs familles est le fait que les praticiens médicaux cachent des informations sur le corps de leurs patients. Cacher des informations aux personnes intersexuées (y compris aux jeunes) retarde le processus d'acceptation de soi et augmente la honte et la stigmatisation. Lorsqu'une personne intersexuée finit par apprendre la vérité, elle se demande toujours : « Pourquoi m'ont-ils caché cette information, à moins qu'il y ait quelque chose de honteux dans mon corps ? » Le secret perpétue également le mythe selon lequel les variations des caractéristiques sexuelles sont extrêmement rares et taboues. En revanche, le partage d'informations d'une manière adaptée à l'âge permet aux personnes de les assimiler, favorise l'autonomisation et facilite l'accès au soutien par les pairs.

Sur le plan social, les personnes intersexuées sont victimes de nombreuses stigmatisations et discriminations, que ce soit à l'école, à la maison, dans les lieux de culte ou de la part de leurs pairs. Il existe une grande incompréhension et une mauvaise interprétation des variations intersexuées au Nigeria, ce qui exacerbe les problèmes d'exclusion sociale, de harcèlement et de manque d'acceptation de la part de la famille, des amis et de la société en général. Au fil du temps, ces expériences ont eu un impact sur la santé mentale et le bien-être psychosocial des personnes intersexuées, leur causant une détresse émotionnelle et un sentiment de non-appartenance, ce qui les pousse à s'isoler et à réprimer leur véritable personnalité et leurs capacités.

En ce qui concerne les relations et la divulgation de leur corps intersexué, les personnes intersexuées s'inquiètent et ne savent pas comment et quand en parler à leur partenaire. Cette incertitude découle des normes sociales, des insécurités personnelles, de la peur d'être jugées, rejetées ou discriminées, et de la possibilité que cette information soit utilisée contre elles, ce qui les laisse isolées et déchirées entre la honte intériorisée et l'autoprotection. Les conséquences psychologiques et émotionnelles du fait de cacher ou de révéler cette information ont un impact significatif sur leur développement et leur santé mentale. De nombreuses personnes intersexuées ont vu leur estime de soi et leur acceptation de soi s'effondrer après avoir été rejetées par des partenaires potentiels ou réels en raison de la variation de leurs caractéristiques sexuelles. La peur du rejet leur laisse constamment un sentiment de honte, de doute de soi et un besoin permanent de réconfort, qu'elles reçoivent rarement dans cette partie du monde.

Pour les personnes qui sont confrontées à ces difficultés particulières et vivent dans une société comme celle du Nigeria, où le discours sur les variations sexuelles et le genre est souvent stigmatisé et mal compris, l'accès à des services et à un soutien en matière de santé mentale inclusifs et spécifiques reste limité. Le manque de sensibilisation et de compréhension des besoins et des problèmes spécifiques des personnes intersexuées en matière de santé mentale au sein du public et chez les professionnels de la santé contribue grandement à cette accessibilité limitée. À cela s'ajoutent les préjugés religieux et culturels, qui créent une stigmatisation socioculturelle. De nombreux prestataires de soins de santé, membres d'institutions gouvernementales et autres continuent de considérer les personnes intersexuées comme un tabou, les associant à la sorcellerie ou à la purification divine, ce qui se manifeste dans leur attitude à leur égard et explique la non-reconnaissance des difficultés et des défis en matière de santé mentale auxquels sont confrontées les personnes intersexuées et leurs familles. *Dans une interview pour la nouvelle étude Intersex Nigeria intitulée Beyond the Binary, une praticienne médicale a déclaré qu'elle considérait les personnes intersexuées comme une erreur de Dieu, raison pour laquelle Dieu leur avait donné les connaissances et les capacités nécessaires pour réparer leur corps.* [31]

Une compréhension limitée des variations intersexuées conduit à la désinformation, aux préjugés et à la discrimination, ce qui a un impact sur la fourniture de services de santé mentale inclusifs et spécifiques aux personnes intersexuées. C'est également la raison pour laquelle, tragiquement, au Nigeria, les institutions gouvernementales, les prestataires de soins de santé et les OSC ne font que peu d'efforts pour répondre aux préoccupations et aux besoins des personnes intersexuées en matière de santé mentale.

[31] https://intersexnigeria.org/resources/epublications

Éthique et Consentement

L'éthique médicale est une composante très importante du système de santé au Nigeria et dans le monde entier. Elle constitue le principe directeur qui garantit la fourniture de soins de santé de qualité, respectueux et inclusifs à tous les patients. Cependant, lorsqu'il s'agit de personnes intersexuées, ces principes sont souvent ignorés, ce qui conduit à leur exclusion des établissements de santé.

Partout en Afrique de l'Ouest, les personnes intersexuées sont victimes de pathologisation et de violations extrêmes de leurs droits humains, car l'intersexualité est considérée en soi comme un trouble. De nombreux professionnels de santé abordent les variations intersexuées comme un problème à « corriger » ou à « normaliser », plutôt que de reconnaître la diversité des corps humains comme un phénomène naturel. Les professionnels de santé sont très prompts à proposer une intervention médicale aux nourrissons intersexués lorsque leurs caractéristiques intersexuées sont détectées à la naissance, sans leur consentement éclairé ni consultation médicale appropriée. Il s'agit d'une pratique courante parmi les prestataires de soins de santé au Nigeria, qui ne tient pas compte du droit à l'autodétermination des personnes et a des répercussions à vie sur leur santé, leur bien-être, leur identité et leur autonomie corporelle.

Au Nigeria, de nombreuses personnes intersexuées subissent des interventions médicales sans avoir reçu les informations adéquates ni avoir eu le choix. Depuis toujours, les personnes intersexuées ont du mal à accéder à des services de santé et à un soutien adaptés et bienveillants, qui sont pratiquement inexistants dans leur milieu. Elles sont constamment contraintes de se soumettre à des interventions chirurgicales irréversibles et médicalement inutiles sans avoir donné leur consentement préalable, libre et pleinement éclairé.

Le consentement éclairé est l'incarnation juridique du concept selon lequel chaque individu a le droit de prendre des décisions concernant sa santé. Il est généralement admis que les patients doivent prendre en considération les risques et les avantages potentiels découlant de leurs décisions médicales. La compréhension par le patient des risques potentiels du traitement proposé est essentielle au consentement médical éclairé.

Le terme « personnel » souligne que seule la personne intersexuée elle-même peut consentir à une telle intervention et que les parents, les tuteurs ou les professionnels de santé ne peuvent se substituer au consentement de la personne intersexuée.

Le terme « préalable » fait référence au moment où le consentement est donné, de sorte qu'un consentement spécifique doit être obtenu avant l'intervention pour laquelle il est demandé. Par exemple, il arrive fréquemment que, bien que le consentement des parents ou de la personne ait été donné pour une intervention spécifique, des chirurgies ou interventions supplémentaires aient été effectuées simultanément sans consentement, puis qu'une tentative ait été faite pour obtenir le consentement a posteriori pour les interventions supplémentaires.

Le terme « libre » fait référence à l'impact des rapports de force qui peuvent diminuer l'autonomie d'une personne et à la pression qui peut avoir une incidence sur la capacité de l'individu à donner son consentement. Par exemple, selon certaines informations, la pression exercée par les prestataires de soins de santé aurait conduit des adultes intersexués à consentir à une intervention qu'ils ne souhaitaient pas, simplement pour que cette pression cesse enfin.

Cependant, en raison du manque de compréhension et de la stigmatisation qui entourent l'intersexualité, de nombreux prestataires de soins de santé ne disposent pas de la formation et des connaissances nécessaires pour traiter ces questions de manière adéquate. La plupart du public, y compris les professionnels de santé, ont une connaissance et une compréhension limitées des variations intersexuées. Ce manque de connaissances perpétue les stéréotypes nuisibles, les idées fausses et les attitudes discriminatoires à l'égard des personnes intersexuées. Celles-ci sont confrontées à l'exclusion sociale, aux préjugés et même à la violence, ce qui limite encore davantage leur capacité à accéder aux services de santé sexuelle et reproductive sans craindre la discrimination ou le jugement.

Dans le rapport *Beyond the Binary,*[32] publié par Intersex Nigeria, il existe un grave manque de connaissances parmi les praticiens médicaux sur les personnes intersexuées, les violations des droits humains auxquelles elles sont confrontées et les besoins spécifiques qui découlent de ces expériences. Ce manque de sensibilisation s'accompagne de préjugés personnels de la part des prestataires de soins de santé, qui peuvent se traduire par de l'incrédulité et des insultes, le refus d'effectuer les examens nécessaires, et des examens réalisés de manière violente ou sans le consentement éclairé de la personne intersexuée. Lors d'une discussion de groupe (FGD) menée par Intersex Nigeria afin de garantir que les personnes intersexuées puissent s'exprimer et contribuer à cette boîte à outils, deux personnes intersexuées ont évoqué le risque de harcèlement sexuel dans les établissements médicaux. Partageant leurs expériences, elles ont mentionné que les médecins avaient touché leurs organes génitaux dans le cadre d'un examen médical nécessaire pour comprendre la taille et la longueur de leurs organes génitaux et leur avaient souvent posé des questions sur leur vie sexuelle et leur demandant de la décrire, le cas échéant. Elles ont décrit cette situation comme gênante et inconfortable, qu'elles ne souhaitent pas revivre. Elles ont mentionné que les examens génitaux n'étaient pas liés à la raison de leur visite à l'hôpital à ce moment-là et qu'elles les avaient plutôt perçus comme une curiosité quant à l'apparence de leurs organes génitaux.

L'invisibilité des personnes nées avec des variations innées des caractéristiques sexuelles dans la société est un autre problème grave. Leur expérience de vie est souvent entourée de secret et de honte, et souvent, les personnes intersexuées elles-mêmes ne sont pas au courant des opérations ou des traitements qui leur ont été infligés pendant leur enfance. L'accès aux dossiers médicaux est souvent très difficile, tout comme l'accès à l'histoire personnelle, y compris les photos d'enfance et autres souvenirs. Les personnes intersexuées qui découvrent leur condition plus tard dans leur vie peuvent subir le même traitement invasif sans leur consentement personnel, préalable, libre et pleinement éclairé que les personnes intersexuées identifiées pendant leur enfance. Malgré cela, certains médecins affirment que le consentement parental suffit pour modifier l'apparence ou la fonction des organes génitaux d'un nourrisson intersexué, y compris les modifications esthétiques du clitoris, tout comme dans le cas des mutilations génitales féminines (MGF). Les chirurgies de « normalisation » génitale intersexuée du clitoris ressemblent fortement aux mutilations génitales féminines (MGF): elles sont généralement non thérapeutiques, motivées par des normes sociales sur l'apparence ou le fonctionnement « normal » du corps, et non par une nécessité médicale. Tout comme les MGF, ces procédures soulèvent de graves préoccupations en matière de droits humains, car elles violent l'intégrité physique, le consentement éclairé et le droit de ne pas subir de traitements dégradants. Pourtant, les expériences des enfants intersexués restent largement invisibles en raison du secret médical, du langage pathologisant et du manque de données. Les survivants font état de dommages physiques et psychologiques durables, tandis que les familles sont souvent soumises à des pressions pour donner leur consentement sans disposer d'informations équilibrées ou d'alternatives. Une meilleure reconnaissance, des rapports transparents, des garanties juridiques et l'accès à des soins fondés sur les droits et différés sont essentiels pour prévenir ces abus.

[32] https://intersexnigeria.org/resources/epublications

Principes Clés de l'Élaboration de Politiques Inclusives

Dans l'élaboration de politiques de santé inclusives pour les personnes intersexuées, de nombreux principes clés sont essentiels pour promouvoir l'égalité d'accès et la qualité des soins pour chaque personne intersexuée. Ces principes clés sont la non-discrimination, l'équité et la participation significative. Ils guideront les décideurs politiques dans l'élaboration de politiques qui répondent aux besoins et aux réalités uniques des personnes intersexuées et de leur communauté, en promouvant un système de santé équitable, impartial et inclusif pour chaque personne intersexuée, de la naissance à l'âge adulte.

Principe de non-discrimination: il est important d'élaborer des politiques qui énoncent explicitement la non-discrimination comme principe fondamental. Ce principe repose sur l'idée que toute personne, indépendamment de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son expression et de ses caractéristiques sexuelles (SOGIESC), doit être traitée de manière égale et sans préjugés. Cela signifie qu'il faut veiller à ce que les personnes présentant des variations intersexuées ne soient soumises à aucune forme de discrimination ou de stigmatisation lorsqu'elles accèdent aux services de santé, et que ces politiques de santé interdisent les pratiques discriminatoires fondées sur des facteurs tels que la race, la religion, le genre, l'orientation sexuelle, le handicap ou le statut socio-économique. Pour y parvenir, les prestataires de soins de santé doivent être formés aux questions liées à l'intersexualité et sensibilisés à l'importance de fournir des soins inclusifs et respectueux aux personnes intersexuées, afin d'éliminer les pratiques discriminatoires et de garantir le droit des personnes intersexuées à accéder à des services de santé complets et adaptés, sans rencontrer d'obstacles injustes ni de préjugés.

Équité: ce principe reconnaît que chacun a des besoins uniques en matière de soins de santé et dispose de ressources variables pour répondre à ces besoins. Les politiques de santé doivent souligner l'importance d'offrir un accès équitable aux soins de santé aux personnes intersexuées, en répondant à leurs besoins. Cela implique de veiller à ce que tous les services de santé nécessaires, y compris les traitements hormonaux, les interventions chirurgicales et le soutien psychologique, soient accessibles à ceux qui en ont besoin. L'équité vise à assurer une répartition équitable des ressources et des services de santé, en veillant à ce que les personnes marginalisées ou défavorisées reçoivent l'aide dont elles ont besoin pour surmonter les obstacles à l'accès aux soins de santé.

Participation: Ce principe reconnaît que les personnes directement concernées par les politiques de santé devraient avoir la possibilité d'exprimer leur point de vue, de contribuer à l'élaboration des politiques et d'influencer les résultats. Il est important d'impliquer les personnes intersexuées et leurs communautés dans le processus d'élaboration des politiques. Il est essentiel de mettre en place des mécanismes de participation et de consultation significatifs, tels que la création de comités consultatifs ou de groupes de travail composés de personnes ayant vécu des expériences liées aux variations intersexuées. Leurs idées et leurs points de vue permettront d'élaborer des politiques qui répondent à leurs besoins et préoccupations individuels.

Engagement des Parties Prenantes

Lors de l'élaboration de politiques inclusives pour les personnes intersexuées, il est essentiel de veiller à ce que leurs voix et leurs points de vue soient pris en compte dans les processus décisionnels. Afin d'élaborer des politiques non discriminatoires, équitables, justes et efficaces, les personnes intersexuées, les prestataires de soins de santé et les groupes de défense doivent tous être impliqués dans le processus décisionnel. Cette implication renforce non seulement la légitimité des politiques, mais offre également un aperçu nécessaire des défis uniques auxquels sont confrontées les personnes intersexuées au Nigeria.

Les personnes intersexuées, les prestataires de soins de santé et les groupes de défense des personnes intersexuées (OSC) joueront tous un rôle important dans le processus d'élaboration de politiques inclusives pour les personnes intersexuées, en particulier en ce qui concerne les droits et les pratiques de soins de santé inclusives. Leur participation est essentielle pour plusieurs raisons.

1. Il est essentiel d'impliquer les personnes intersexuées, car elles sont directement concernées par ces politiques et peuvent partager leurs expériences vécues. Les politiques qui ont un impact direct sur les personnes intersexuées, telles que celles régissant l'accès aux soins de santé, les interventions médicales et la reconnaissance juridique, doivent être adaptées à leurs besoins et à leurs préférences. La prise en compte de leurs points de vue permet de garantir que ces politiques sont conçues pour répondre à leurs besoins, droits et préoccupations spécifiques. Lorsque les personnes intersexuées sont directement impliquées dans les processus décisionnels, les décideurs politiques acquièrent une meilleure compréhension de leurs expériences vécues, ce qui conduit à des politiques plus inclusives à leur égard tout en favorisant le respect de leur autonomie corporelle, de leur dignité et de leur autodétermination.

2. Les prestataires de soins de santé sont en première ligne pour fournir des soins aux personnes intersexuées. Ils doivent également être impliqués car, en tant que professionnels, ils possèdent des connaissances et des informations précieuses sur les besoins médicaux et psychologiques des personnes intersexuées au Nigeria, ainsi qu'une compréhension approfondie des implications médicales et éthiques des lacunes et des préjugés politiques du pays. Leur implication garantira que les mesures proposées sont conformes aux meilleures pratiques médicales et s'appuient sur des recherches fondées sur des preuves. En outre, les prestataires de soins de santé peuvent apporter un éclairage supplémentaire sur les implications sanitaires des politiques et pratiques néfastes du pays qui limitent l'accès et la fourniture de services de santé de qualité aux personnes intersexuées au Nigeria. Afin d'éviter toute lacune, seuls les prestataires de soins de santé ayant une connaissance approfondie de la santé et des questions liées à l'intersexualité, ainsi que ceux qui ne présentent aucun préjugé ou conflit d'intérêts personnel, devraient être pris en considération.

3. L'inclusion de groupes de défense dirigés par des personnes intersexuées et axés sur cette question est essentielle pour amplifier la voix des personnes intersexuées et communiquer leurs préoccupations aux décideurs politiques. Les militants et les groupes de défense travaillent depuis longtemps sans relâche pour promouvoir les droits des personnes intersexuées, remettre en question les normes sociales néfastes et plaider en faveur de réformes législatives. Leur participation garantira que les initiatives locales et les points de vue des communautés éclairent le processus d'élaboration des politiques. Ils apporteront également une contribution précieuse aux projets de politique, proposeront des solutions alternatives et aideront les décideurs politiques à naviguer dans les questions sensibles entourant les droits des personnes intersexuées, tout en fournissant des documents sur les exclusions en matière de soins de santé et les expériences discriminatoires vécues par les personnes intersexuées lorsqu'elles cherchent à obtenir et à accéder à des services de santé dans les établissements de santé nigérians.

Conception et Mise en Oeuvre de Politiques en Faveur des Personnes Intersexuées

Les besoins en matière de soins de santé des personnes intersexuées sont souvent négligés et largement méconnus, ce qui conduit à des pratiques discriminatoires et à un soutien inadéquat, en particulier dans les centres de soins. Il est essentiel de concevoir et de mettre en oeuvre des politiques de santé inclusives et affirmatives pour les personnes intersexuées afin de garantir un accès égal à des soins de santé de qualité. Vous trouverez ci-dessous les étapes clés à suivre pour concevoir et mettre en oeuvre ces politiques recommandées.

Étape 1: Comprendre et Reconnaître les Réalités Intersexuées.

La première étape à franchir dans la conception d'une politique inclusive pour les personnes intersexuées consiste à acquérir une compréhension globale des différentes variations intersexuées qui existent dans le monde, de leurs implications médicales et de leurs besoins spécifiques en matière de soins de santé. Cela implique de veiller à ce que les groupes de défense des droits des personnes intersexuées, les militants intersexués, les professionnels de la santé et les personnes concernées elles-mêmes soient explicitement impliqués. De plus, la constitution d'une base solide de gestion des connaissances, de données et de ressources sur les questions intersexuées contribuera à établir des fondements solides pour une conception efficace des politiques.

Étape 2: Sensibiliser et Éduquer

Il est essentiel de sensibiliser le public aux différences intersexuées et aux besoins en matière de soins de santé qui y sont associés afin de remettre en question les préjugés culturels, les normes sociales, les croyances religieuses et les idées fausses. Cette étape consiste à créer des programmes éducatifs tels que des supports d'information, d'éducation et de communication (IEC), des cours de formation et d'autres ressources pédagogiques destinés aux prestataires de soins de santé, aux décideurs politiques, aux défenseurs des droits humains et au grand public. Ces initiatives doivent donner la priorité au consentement éclairé, à l'autonomie corporelle et au respect des droits des personnes intersexuées, qui font partie des besoins fondamentaux des personnes intersexuées au Nigeria.

Étape 3: Élaboration et Mise en Oeuvre de Politiques

Après avoir jeté les bases pour comprendre les réalités intersexuées et sensibiliser le public à leurs besoins en matière de soins de santé et aux lacunes politiques, la phase d'élaboration des politiques commencera, en mettant l'accent sur la traduction des connaissances et de la compréhension en politiques concrètes. C'est à ce stade que les personnes intersexuées, les prestataires de soins de santé, les militants intersexués, les groupes de défense dirigés et axés sur les personnes intersexuées et les décideurs politiques se réuniront. Cette phase comprend la rédaction de lignes directrices, de protocoles et de normes de soins que les prestataires de soins de santé au Nigeria devront suivre lorsqu'ils s'occupent de patients intersexués et leur prodiguent des soins. Ces politiques aborderont des questions telles que la couverture complète des soins de santé, les interventions médicales appropriées, le consentement pleinement éclairé, la confidentialité, l'accès aux rapports médicaux, le soutien en matière de santé mentale et l'interdiction des chirurgies inutiles ou forcées, parmi beaucoup d'autres.

Étape 4: Suivi et Évaluation

À ce stade, il est essentiel de mettre en place des mécanismes de suivi et d'évaluation de l'efficacité des politiques de santé inclusives envers les personnes intersexuées qui ont été élaborées. La collecte de données sur les résultats des soins de santé, les expériences des patients et les obstacles à l'accès aux soins devrait faire partie de la pratique courante. L'évaluation régulière des politiques permettra d'identifier les lacunes, les défis et les domaines à améliorer.

Étape 5: Collaboration et Engagement

La collaboration avec les organisations de défense des personnes intersexuées, les professionnels de santé, les décideurs politiques et les personnes concernées est essentielle tout au long du processus d'élaboration et de mise en oeuvre des politiques. L'implication des personnes intersexuées dans les processus décisionnels garantit que leurs voix et leurs expériences sont prises en compte et respectées.

Exemples de Bonnes Pratiques en Matière de Politique Intersexuée

Le Kenya a pris des mesures importantes pour reconnaître les personnes intersexuées dans les systèmes d'enregistrement légal et civil. Les décisions de justice et les réformes administratives ont amélioré la reconnaissance des personnes intersexuées dans les documents officiels et renforcé la sensibilisation du public aux droits des personnes intersexuées. Ces efforts illustrent comment la reconnaissance juridique peut réduire l'invisibilité et faciliter l'accès aux services, y compris aux soins de santé.

Le Territoire de la capitale australienne a mis en place un cadre réglementaire qui impose des procédures d'autorisation pour certains traitements médicaux ayant une incidence sur les variations des caractéristiques sexuelles. La politique met l'accent sur le report des interventions différées jusqu'à ce que les personnes concernées puissent participer de manière significative à la prise de décision. Cette approche montre comment la réglementation des soins de santé peut concilier les considérations médicales et la protection des droits humains.

À Malte, le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé ont collaboré pour introduire dans les écoles des programmes d'éducation sexuelle complets incluant les personnes intersexuées. Ces programmes sensibilisent les élèves aux questions liées à l'intersexualité, favorisant ainsi la compréhension et l'acceptation dès le plus jeune âge.

L'Allemagne, par l'intermédiaire de son réseau pour les discours sur l'intersexualité, a élaboré la « Déclaration consensuelle interdisciplinaire sur les soins aux personnes présentant des variations du développement sexuel ». Cette déclaration consensuelle fournit des orientations aux prestataires de soins de santé sur la prise en charge éthique et fondée sur des preuves des conditions intersexuées, favorisant ainsi des pratiques de soins de santé plus inclusives et plus solidaires.

En Argentine, l'Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) travaille en étroite collaboration avec la communauté pour collecter des données et surveiller la mise en oeuvre des politiques inclusives envers les personnes intersexuées. Cette approche fondée sur les données fournit des informations précieuses pour l'amélioration des politiques.

L'Institut néerlandais des droits de l'homme implique activement les personnes intersexuées dans les discussions politiques par le biais de son groupe d'experts sur l'intersexualité. Cette approche garantit que les politiques sont fondées sur les expériences vécues par les personnes intersexuées et leurs besoins spécifiques en matière de soins de santé.





Lignes Directrices à l'Intention des Prestataires de Soins de Santé

- Respectez les droits humains et l'identité des nourrissons, des enfants, des adolescents et des adultes présentant des variations intersexuées. Cela implique notamment de reporter les interventions médicales non urgentes et irréversibles telles que les chirurgies génitales.

- Veiller à obtenir le consentement éclairé du patient pour tout traitement médical ou chirurgical susceptible d'avoir un impact sur l'apparence génitale, les gonades ou la fertilité, ainsi que pour tout traitement qui semble reposer sur des stéréotypes sociaux, culturels ou de genre, tels que l'idée que les garçons doivent être capables d'uriner debout.

- Les prestataires de services de santé doivent veiller à ce que toutes les procédures, tous les traitements et toutes les interventions chirurgicales soient expliqués de manière claire et exhaustive aux personnes intersexuées et à leurs familles. Obtenir leur consentement éclairé, en leur fournissant toutes les informations pertinentes, les risques potentiels et les alternatives, et en leur permettant de prendre des décisions éclairées concernant leurs propres soins de santé, sans aucune forme de coercition ou d'influence.

- Les prestataires de soins de santé doivent veiller à ce que les personnes intersexuées aient accès à des conseils et à un soutien psychologiques et psychosociaux spécialisés et adaptés à chaque individu, ainsi qu'à leurs familles, dès le moment où elles se présentent spontanément ou reçoivent un diagnostic, et aussi longtemps que nécessaire.

- Les professionnels de santé et les directeurs doivent régulièrement évaluer et mettre à jour les politiques et pratiques en matière de soins de santé afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux meilleures pratiques actuelles dans le monde et aux normes internationales en matière de droits humains. Ils doivent régulièrement solliciter l'avis des personnes intersexuées et d'autres groupes marginalisés afin de les impliquer dans les processus décisionnels, en veillant à ce que leurs voix soient entendues, valorisées et prises en compte lors de l'amélioration des services de santé.

- Utilisez un langage inclusif envers les personnes intersexuées, qui fournit des conseils utiles sur la manière de parler avec et au sujet des personnes intersexuées de manière respectueuse.

- Les prestataires de soins de santé doivent adapter les plans de soins de santé de manière à répondre aux besoins et aux objectifs spécifiques de chaque patient intersexué. Il convient de reconnaître qu'il existe un large éventail de variations intersexuées et que l'expérience de chaque personne peut être différente.



Recommandations à l'Intention des Organismes Gouvernementaux

- Le ministère fédéral de la Justice (FMOJ), le ministère fédéral de la Santé et des Affaires sociales (FMOHSW), les organisations dirigées par des personnes intersexuées et d'autres OSC devraient collaborer pour garantir la formulation, l'adoption, la mise en oeuvre et l'application de lois et de politiques nationales visant à mettre fin aux traitements « normalisants » médicalement inutiles des personnes intersexuées, y compris les chirurgies génitales irréversibles et la stérilisation, lorsqu'ils sont imposés ou administrés sans le consentement libre et pleinement éclairé de la personne concernée. Les traitements d'assignation sexuelle devraient être proposés aux personnes intersexuées à un âge où elles peuvent exprimer leur consentement libre et pleinement éclairé. Nous devons respecter le droit des personnes intersexuées à ne pas subir de traitement d'assignation sexuelle.

- Les institutions gouvernementales telles que le ministère fédéral de la Santé et des Affaires sociales (FMOHSW) devraient mettre en place une formation obligatoire pour les professionnels de la santé, tels que les médecins, les sages-femmes, les psychologues et autres professionnels travaillant dans le secteur de la santé (par exemple, le personnel d'accueil), afin de garantir que les personnes intersexuées et leurs familles aient accès à des soins de santé adéquats et soient protégées contre la discrimination. La formation devrait inclure des informations sur la vulnérabilité et les besoins particuliers des personnes intersexuées dans le milieu médical.

- La Commission nationale des droits de l'homme du Nigéria devrait mener des actions de sensibilisation et de soutien public en faveur des personnes intersexuées, y compris les enfants. Elle devrait clairement affirmer sa mission de travailler sur les questions liées aux personnes intersexuées et leur fournir des services d'aide aux victimes en cas de violations.

- La Commission nationale de gestion de l'identité (NIMC) devrait veiller à ce que des procédures souples soient respectées lors de l'attribution et de la réattribution du sexe/genre dans les documents officiels.

- Le ministère fédéral de la Santé et des Affaires sociales (FMOHSW) et le département de la Planification, de la Recherche et des Statistiques (PRS), en collaboration avec les groupes de défense des personnes intersexuées, devraient mener des recherches sur la situation et les besoins en matière de protection des droits humains des personnes intersexuées dans différents contextes. Il est urgent de sensibiliser le public et d'améliorer la formation professionnelle sur les problèmes rencontrés par les personnes intersexuées et d'élaborer des mesures qui renforcent la pleine jouissance de leurs droits humains.

- Le ministère fédéral de la Santé et des Affaires sociales (FMOHSW) devrait veiller à créer des procédures opérationnelles standardisées pour les naissances intersexuées dans les hôpitaux, qui pourraient inclure : un registre et un dossier intersexués dans les hôpitaux publics et privés, y compris les hôpitaux universitaires, et les naissances facilitées par des accoucheuses traditionnelles afin de garantir une documentation claire des naissances intersexuées dans tout le pays.

- Le ministère fédéral de la Santé et des Affaires sociales (FMOHSW) devrait rendre obligatoire l'intégration de l'éducation sur l'intersexualité dans le programme d'études médicales de toutes les formations de premier cycle des facultés de médecine.

- Le ministère fédéral de l'Éducation (FMOE) devrait envisager d'inclure les personnes intersexuées et l'existence de variations dans les caractéristiques sexuelles d'une manière positive et valorisante dans les programmes scolaires, les manuels et le matériel pédagogique afin d'améliorer la compréhension du grand public sur la qualité du sexe en tant que spectre et l'existence des personnes intersexuées, et de renforcer la confiance en soi des enfants et adolescents intersexués.

- D'autres agences gouvernementales, notamment le ministère fédéral de la Santé et des Affaires sociales (FMOHSW), devraient investir dans le financement de groupes et d'organisations intersexués afin qu'ils puissent s'engager dans des projets proposant des formations aux professionnels de la santé, aux sages-femmes, aux psychologues et aux autres professionnels travaillant dans le domaine de la santé physique et mentale.





Appel à l'Action Pour les OSC

Les défenseurs des personnes intersexuées s'engagent à mettre fin à ces pratiques néfastes et à permettre aux personnes intersexuées de faire des choix concernant leur propre corps.

- Les organisations de défense des droits de l'enfant et des droits humains devraient organiser des formations axées sur les droits humains concernant l'existence des personnes intersexuées et leurs besoins spécifiques à l'intention d'autres OSC de défense des droits humains afin de renforcer leur capacité à comprendre ces besoins, à les inclure dans leurs propres demandes en matière de défense de la santé, lors de la formation des prestataires de soins de santé, et à les aider à orienter correctement les personnes intersexuées qui ont ces besoins lorsqu'elles entrent en contact avec elles.

- La Journée de sensibilisation à l'intersexualité est célébrée chaque année le 26 octobre et marque l'anniversaire de la première manifestation publique contre les chirurgies génitales non consenties sur les nourrissons aux États-Unis en1996. Découvrez l'histoire de la défense des droits des personnes intersexuées et ce que vous pouvez faire pour faire entendre leur voix.

- Les OSC peuvent soutenir les efforts des organisations dirigées par des personnes intersexuées et axées sur cette question afin de documenter et de diffuser les bonnes pratiques en matière de défense des droits des personnes intersexuées dans le système de santé et auprès des prestataires de soins de santé au Nigeria.

- Les OSC doivent collaborer avec les organisations dirigées par des personnes intersexuées et axées sur cette question afin de garantir une participation et une inclusion adéquates de l'agenda intersexué dans les examens du secteur de la santé et autres processus pertinents susceptibles de promouvoir l'inclusion des personnes intersexuées dans les soins de santé.

- Familiarisez-vous, ainsi que votre organisation, avec les déclarations, documents, traités et procédures internationaux qui promeuvent les droits des personnes intersexuées, y compris l'accès inclusif aux soins de santé, et comprenez le contexte national en matière de santé, afin de paraître bien informé, professionnel et réactif face aux nombreuses pressions exercées par le gouvernement et de défendre efficacement l'inclusion des personnes intersexuées dans le domaine de la santé.

- Les OSC qui travaillent sur les mutilations génitales féminines (MGF), les enfants et les adolescents devraient développer des webinaires, du matériel d'apprentissage en ligne et créer un espace en ligne pour les OSC qui travaillent sur l'inclusion des personnes intersexuées dans les systèmes de santé afin de partager des expériences et des études de cas et de permettre des échanges et des communications collaboratifs

- Les OSC qui ont plus d'expérience et des représentants dans les secteurs politiques devraient apporter leur soutien aux organisations dirigées par des personnes intersexuées et axées sur cette question afin de tirer parti de ce partenariat établi pour diffuser leurs rapports aux niveaux national, régional et mondial afin d'atteindre le public cible et d'obtenir des résultats plus rapides.

SECTION 7 — Conclusion et Annexes

Conclusion

Au milieu des années 1990, les personnes intersexuées et leurs défenseurs à travers le monde ont commencé à remettre en question les pratiques médicales néfastes actuellement appliquées aux corps intersexués. En relativement peu de temps, le mouvement intersexué a sensibilisé le public aux problèmes de santé auxquels est confrontée la communauté intersexuée et a entamé un dialogue et des interventions fructueux avec les professionnels de la santé. Cependant, environ 95 % des médecins recommandent toujours aux parents de nouveau-nés intersexués de consentir à des chirurgies génitales médicalement inutiles et préjudiciables pour leurs enfants.[33] La plupart des parents suivent les conseils de leur médecin et approuvent ces procédures.

Bien que la loi nigériane sur les droits de l'enfant (CRA)[34] accorde une grande déférence aux parents en ce qui concerne les décisions médicales prises au nom de leurs enfants, les procédures traditionnelles de consentement éclairé sont insuffisantes pour protéger l'intérêt supérieur des enfants intersexués au Nigeria. Des politiques et des procédures devraient être mises en place pour contrôler ces processus pour les raisons suivantes :

- **Les interventions chirurgicales ont un impact négatif sur des droits importants.** Elles peuvent affecter les capacités d'une personne, entraîner des complications et des douleurs à vie, des cicatrices, des traumatismes, une faible estime de soi, etc. Les interventions chirurgicales qui affectent un droit important protégé par la Constitution ne devraient être pratiquées qu'avec le consentement éclairé de la personne qui subit l'intervention. Si la personne soumise au traitement n'est pas en mesure de donner son consentement, des mesures de protection supplémentaires devraient être imposées afin de garantir que ces droits importants ne soient pas violés.

- **Les parents peuvent ne pas être en mesure de comprendre pleinement l'intérêt supérieur de leur enfant.** Lorsque les parents prennent ces décisions, ils envisagent leurs enfants comme des enfants et non comme des êtres sexuels adultes. Une étude[35] a montré que les parents consentent à ces interventions médicales parce qu'ils se soucient du bien-être émotionnel de leurs enfants. D'autres études[36,37] ont indiqué que la majorité des adultes ne souhaiteraient pas que leurs parents consentent à ces opérations, en particulier s'il existe un risque que l'intervention médicale affecte leur capacité à avoir des relations sexuelles satisfaisantes. Par conséquent, ces interventions ne devraient pas être pratiquées dans le cadre des pratiques traditionnelles de consentement parental.

[33] Fixé à la naissance : effacement médical et juridique des variations intersexuées. A Kennedy. Journal juridique de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, The 39 (2), 813-842, 2016. 24, 2016.
[34] Loi sur les droits de l'enfant, 2003, loi n° 26, Lois de la Fédération du Nigeria, 2003.
[35] Dayner, J. E., Lee, P. A., & Houk, C. P. (2004). Traitement médical de l'intersexualité : perspectives parentales. Journal of Urology, 172(4 Pt 2), 1762–1765. https://doi.org/10.1097%ju.0000138519.12573.3a
[36] Minto, C. L., Liao, L.-M., Woodhouse, C. R. J., Ransley, P. G., & Creighton, S. M. (2003). L'effet de la chirurgie clitoridienne sur la sexualité chez les personnes intersexuées présentant des organes génitaux ambigus : une étude transversale. The Lancet, 361(9365), 1252–1257. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)12980-7
[37] Crouch, N. S., Liao, L.-M., Woodhouse, C. R. J., Conway, G. S., & Creighton, S. M. (2008). Fonction sexuelle et sensibilité génitale après une génitoplastie féminisante pour hyperplasie congénitale des surrénales. The Journal of Urology, 179(2), 634–638. https://doi.org/10.1016/j.juro.2007.09.079

- **Ces procédures médicales sont fondées sur des stéréotypes liés au sexe, au genre et à l'orientation sexuelle.** Bien que certains nourrissons présentant des organes génitaux atypiques doivent subir des interventions pour corriger des anomalies qui menacent leur santé, la plupart des corps intersexués ne présentent aucun risque pour la santé. La plupart de ces interventions chirurgicales sont réalisées pour des raisons purement esthétiques. Elles sont pratiquées sur la base de stéréotypes erronés liés au sexe, au genre et à l'orientation sexuelle, notamment l'hypothèse selon laquelle les femmes privilégient l'apparence esthétique au plaisir sexuel, les hommes ont besoin d'un pénis qui leur permette d'uriner debout, et tous les hommes et toutes les femmes souhaitent avoir des rapports sexuels traditionnels. Les stéréotypes liés au sexe ne devraient pas être utilisés pour justifier des pratiques médicales qui changent le cours d'une vie.

- **Ces interventions chirurgicales ne sont pas pratiquées parce que ces nourrissons sont handicapés, mais parce qu'ils sont perçus comme ayant un handicap et devant être « corrigés ».**La plupart des nourrissons présentant des variations intersexuées sont capables d'accomplir toutes les fonctions vitales importantes, sont en parfaite santé et ne sont ni handicapés ni atteints d'unhandicap. Malheureusement, les bébés intersexués sont soumis à des interventions médicales invasives, irréversibles et potentiellement dangereuses afin de rendre leur corps conforme aux normes sociales. Souvent, ces interventions médicales inutiles entraînent des problèmes physiques et émotionnels qui n'existaient pas auparavant, tels que la stérilité, l'anxiété et la dépression. En outre, les personnes perçues comme handicapées ne devraient pas être soumises à des procédures invasives visant à conformer leur corps aux attentes de la société. La solution n'est pas la modification chirurgicale de l'enfant, mais l'éducation de la société à accepter la diversité des corps.

- **Aucune étude n'a prouvé que les chirurgies génitales esthétiques sont bénéfiques pour les personnes intersexuées, alors qu'il existe des preuves que ces procédures peuvent entraîner de graves dommages physiques et émotionnels.** Compte tenu des intérêts en jeu, les tribunaux et les législateurs devraient envisager d'imposer des garanties juridiques afin de s'assurer que les décisions en matière de soins de santé prises au nom des enfants intersexués sont réellement dans leur intérêt supérieur. Les institutions juridiques devraient envisager d'imposer un moratoire sur ces interventions jusqu'à ce que leur bénéfice soit prouvé, en renforçant les pratiques de consentement éclairé pour ces interventions ou en exigeant un contrôle externe ou l'approbation d'un tribunal ou d'un comité d'éthique hospitalier. Les féministes, les militants pour les droits des personnes intersexuées et les défenseurs des droits humains dénoncent depuis longtemps le fait que la discrimination fondée sur les stéréotypes liés au sexe, au genre et à l'orientation sexuelle constitue une discrimination sexuelle illégale.

- **La discrimination dans les soins de santé devrait être interdite.** Le ministère fédéral de la Santé et des Affaires sociales (FMOHSW) devrait élaborer des procédures éthiques et des protocoles médicaux qui protègent la vie des personnes intersexuées, notamment en veillant à ce que toute intervention chirurgicale inutile, y compris la stérilisation forcée, ou l'attribution d'un genre n'ait lieu que lorsque l'enfant est en mesure de participer à la prise de décision, dans son intérêt supérieur. Le principe de participation et d'implication s'étend à toutes les personnes intersexuées. L'implication significative des personnes intersexuées devrait toujours être au coeur de toute décision médicale.

- **L'implication des personnes intersexuées dans l'élaboration des politiques et des directives en matière de santé est tout aussi essentielle pour protéger et promouvoir les droits humains.** En outre, malgré la diffusion croissante d'informations sur les personnes intersexuées via les réseaux sociaux, celles-ci continuent de se heurter à une incompréhension de leur statut au-delà de la conception binaire des corps masculins ou féminins au Nigeria. Cela conduit à la création de stéréotypes, qui se traduisent par une marginalisation et une discrimination dans les espaces de soins de santé. Des efforts accrus pour garantir la participation des personnes intersexuées aux forums de prise de décision et leur représentation dans les structures de soins de santé contribueront à renforcer leur voix.

- **Il existe au Nigeria diverses possibilités de mieux protéger et promouvoir les droits des personnes intersexuées,** sur la base d'une réforme législative et politique guidée par les principes mondiaux, régionaux et nationaux en matière de droits humains et les enseignements tirés de la législation nationale comparative dans diverses juridictions telles que le Kenya, l'Afrique du Sud et Malte, qui montrent notamment l'importance de définir clairement et de garantir les droits des personnes intersexuées dans des lois et politiques générales et spécifiques dans divers secteurs, en particulier les soins de santé ; interdire les interventions médicales inutiles ; permettre la modification des documents d'identité essentiels ; sensibiliser davantage aux droits des personnes intersexuées ; et renforcer l'accès à la justice en cas de violation des droits.

Nous, les personnes intersexuées, exigeons: la reconnaissance de nos expériences, car nos variations font partie de la diversité humaine. Lorsque nous sollicitons des services de santé, veuillez respecter notre vie privée, car nous ne sommes pas des cobayes ; être examinés par une équipe de médecins alors que cela n'est pas nécessaire en une seule fois est déshumanisant. Il est important que le personnel de santé nous fournisse une aide médicale impartiale et que les organismes gouvernementaux disposent d'informations adéquates et complètes grâce à des politiques et des lois visant à soutenir les personnes intersexuées et leurs parents, accompagnées d'un soutien psychosocial pour notre bien-être et notre développement.

Annexes

Glossaire

OSC Organisation de la Société Civile
MGI Mutilation Génitale Intersexuée
MGF Mutilations Génitales Féminines
IEC Information, Éducation et Communication (supports)
FMOH Ministère Fédéral de la Santé
FMOJ Ministère Fédéral de la Justice
FMOE Ministère Fédéral de l'Éducation
FGD Discussion de Groupe
VAPP Loi sur l'Interdiction de la Violence à l'Égard des Personnes
CRA Loi sur les Droits de l'Enfant
DPRS Département de la Planification, de la Recherche et des Statistiques
NIMC Commission Nationale de Gestion de l'Identité
NHC Commission Nationale des Droits de l'Homme
ONG Organisation non Gouvernementale
SGBV Violence Sexuelle et Sexiste
SRHR Santé et Droits Sexuels et Reproductifs
ONU Nations Unies
OMS Organisation Mondiale de la Santé

Ressources Supplémentaires

Déclarations

1. Déclaration de Malte (2013). Organisation Intersex International. (2013). Déclaration publique du troisième Forum international intersexué (Déclaration de Malte). https://oiieurope.org/malta-declaration/
2. Déclaration de Darlington (2017). Organisations intersexuées d'Australie et d'Aotearoa/Nouvelle-Zélande. (2017). Déclaration de Darlington : déclaration commune consensuelle issue de la retraite de la communauté intersexuée. https://darlington.org.au/statement/
3. Principes de Yogyakarta (2007) Commission internationale de juristes. (2007). Principes de Yogyakarta sur l'application du droit international des droits humains en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre. http://yogyakartaprinciples.org/
4. Principes de Yogyakarta +10 (2017) Commission internationale de juristes. (2017). Principes de Yogyakarta +10 : Principes supplémentaires et obligations des États. http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf

Législation et politiques

Afrique

- Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) – Résolution 552 (2023). https://achpr.au.int/en/adopted-resolutions/resolution-promotion-and-protection-rights-intersex-persons?
- Kenya – Loi n° 29 de 2022 sur les enfants; réformes administratives (2025). La loi reconnaît les enfants intersexués et impose une documentation/un enregistrement appropriés et un traitement fondé sur la dignité (par exemple, art. 7(3), art. 21). Le Kenya a également pris des mesures pour inclure la mention « Intersexué (I) » sur les avis de naissance/certificats de naissance via un modèle publié au Journal officiel en 2025. knchr.orgSquarespaceThe StarSABC
- Kenya – Rapport du groupe de travail gouvernemental (2019). Plan officiel recommandant des réformes juridiques, du système de santé et de l'état civil pour les personnes intersexuées. Kenya Law
- Afrique du Sud – Loi sur l'égalité (PEPUDA) telle que modifiée (2005). Ajoute l'intersexualité au motif légal du « sexe », renforçant ainsi les protections contre la discrimination. Base de données Translaw d'Asie du Sud
- Afrique du Sud – Loi n° 49 de 2003 sur la modification de la description et du statut sexuels. Permet aux personnes intersexuées (et autres) de modifier leur sexe légal dans le registre de la population. Gouvernement d'Afrique du Sud

Mondial

- Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. (8 août 2025). Lois et politiques discriminatoires, actes de violence et pratiques préjudiciables à l'égard des personnes intersexuées (rapport au Conseil des droits de l'homme, 60e session, document des Nations Unies A/HRC/60/50). Nations Unies. https://docs.un.org/en/A/HRC/60/50
- Résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies (4 avril 2024). Première résolution des Nations Unies sur les personnes intersexuées — appelle les États à lutter contre la discrimination, la violence et les pratiques médicales préjudiciables ; mandate un rapport du HCDH. Bibliothèque numériqueReutersHCDH
- Note technique du HCDH (2023). Consolide les normes relatives aux droits humains et les bonnes pratiques pour la protection des personnes intersexuées (santé, non-discrimination, intégrité physique). HCDH
- Conseil de l'Europe, résolution 2191 (2017) de l'APCE. Orientations complètes pour mettre fin aux interventions médicales non consenties et à la discrimination à l'égard des personnes intersexuées. assembly.coe.int
- Résolution du Parlement européen (2019). Invite les États membres de l'UE à protéger l'intégrité physique des personnes intersexuées et à interdire les traitements « normalisants » non consentis. Parlement européen

Europe (législation nationale)

- Malte – Loi GIGESC (2015). Première interdiction légale au monde des interventions médicales non consenties et non vitales sur les mineurs intersexués ; protège les caractéristiques sexuelles. legislation.mtDirection des droits de l'homme
- Portugal – Loi 38/2018. Protège les caractéristiques sexuelles et restreint les interventions médicales sur les mineurs intersexués (en cas d'urgence ou sous réserve de garanties strictes). Base de données de l'ILGA
- Allemagne – Loi de 2021 (« Gesetz zum Schutz von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung »). Restreint/supervise les interventions chirurgicales sur les enfants intersexués incapables. Commission internationale de juristes
- Grèce – Loi 4958/2022. Interdit les interventions chirurgicales médicalement inutiles sur les mineurs intersexués sans leur consentement (à quelques exceptions près). Corte Constitucional
- Espagne – Loi 4/2023 (art. 19). Réglemente la santé des personnes intersexuées ; interdit les pratiques de modification génitale sur les enfants de moins de 12 ans (sauf exceptions médicales), fixe des règles de consentement pour les 12-16 ans. Juridicas News Base de données ILGA
- Islande – Loi n° 80/2019 (autonomie de genre). Protège l'intégrité physique ; les modifications permanentes des caractéristiques sexuelles nécessitent le consentement, avec des garanties spécifiques pour les enfants. Government.is+1

Amériques

- Chili – Circulaire n° 15/2023 du ministère de la Santé. Interdit les interventions chirurgicales/traitements non consentis et non vitaux sur les nouveau-nés, les enfants et les adolescents intersexués ; remplace les règles antérieures. DIPRECE
- Colombie – Cour constitutionnelle SU-337/1999 (et jurisprudence connexe). Établit des normes historiques en Amérique latine en matière de consentement et de calendrier des interventions médicales sur les enfants intersexués. Saflii

Asie-Pacifique

- AAustralie (ACT) – Loi de 2023 sur la variation des caractéristiques sexuelles (traitement médical restreint). Établit un régime d'approbation/de surveillance et interdit les procédures différées/irréversibles sur les personnes prescrites (y compris les mineurs sans capacité). legislation.act.gov.au
- Inde (Tamil Nadu) – Décret gouvernemental G.O.(Ms) 355 (2019). Interdit les opérations chirurgicales non vitales sur les nourrissons/enfants intersexués (décret exécutif suivant les directives de la Haute Cour). Human Rights WatchBase de données Translaw sur l'Asie du Sud

Documentaires

- Intersex Nigeria. (2025). In-Between Sexes [Documentaire]. Nigeria : https://youtu.be/iqR08YvUPIg?si=OboEurHCLQn4HRis
- Skovrán, T. (Réalisateur). (2023). Who I Am Not [Film documentaire]. (Afrique du Sud). PBS
- Lahood, G. (réalisateur). (2012). Intersexion [documentaire]. Ponsonby Productions. Wikipédia
- Skovrán, T. (Réalisateur). (2023). Who I Am Not [Documentaire]. Afrique du Sud/Roumanie/Canada/Allemagne/États-Unis : POV/Greenwich Entertainment. PBSWikipediaFrameline
- Aitchison, T. (Réalisateur). (2018). Sidney & Friends [Documentaire]. Kenya/Royaume-Uni. Rotten TomatoesIMDb
- Mokoena, N., & le Roux, G. (Réalisateurs). (2019). Reclaiming Intersex (while Black, Genderqueer and Feminist in South Africa) [Court métrage documentaire]. Afrique du Sud. uwc.ac.zaTaboom Media
- Iranti & Intersex South Africa. (2024). Parents of Intersex Children—Their Experience with Healthcare [Court métrage documentaire]. Afrique du Sud : Iranti. beyondthemargins.africaYouTube
- Bernier-Clarke, A. (Réalisatrice). (2019). A Normal Girl [Court métrage documentaire]. Women Make Movies. wmm.com
- Hart, P. (Réalisateur). (2010). Orchids: My Intersex Adventure [Film documentaire]. Women Make Movies. wmm.com

Documentaries

- Devigne, F. (Réalisateur). (2018). No Box for Me : An Intersex Story [Film documentaire]. (France/Suisse). Visions du Réel
- Pang, Y., & Tokanel, R. (Réalisateurs). (2019). She's Not a Boy [Court métrage documentaire]. Pulitzer Center. intersexday.org
- HermaphroditesSpeak! (Documentaire issu de la première retraite intersexuée 1995, États-Unis 1996, https://www.youtube.com/watch?v=VMER3_nxlN0
- Zieselman, K. M. (producteur exécutif) et Robertson, R. (scénariste et réalisateur). (2024). Common as Red Hair [Court métrage]. R&R Productions https://www.primevideo.com/detail/Common-as-Red-Hair/0GCIC6EK020LL8V908OZO4J51A

Articles et Rapports

- Intersex Nigeria. (Octobre 2024). Visibilité, inclusion et reconnaissance des personnes intersexuées au Nigeria : étude de référence sur la perception publique des personnes intersexuées et des mutilations génitales intersexuées au Nigeria. Intersex Nigeria. https://www.intersexnigeria.org/pdfs/VIRAL%20ENG%20NIG.pdf
- Intersex Nigeria. (Juin 2024). Manuel stratégique sur la défense des droits des personnes intersexuées au Nigeria.https://www.intersexnigeria.org/pdfs/Strategic%20Advocacy%20Manual%20INTERSEX%20RIGHT.pdf
- Intersex Nigeria. (2023). Boîte à outils sur les droits sexuels et reproductifs des personnes intersexuées. Intersex Nigeria. https://www.intersexnigeria.org/pdfs/Intersex%20SRHR%20TOOLKIT.pdf
- Intersex Nigeria. (2023). Au-delà du binaire : explorer la diversité des identités et des expériences intersexuées. Intersex Nigeria. https://www.intersexnigeria.org/pdfs/BEYOND-THE-BINARY.pdf
- Dreger, A. D. (1998). « Sexe ambigu » ou médecine ambivalente ? Hastings Center Report, 28(3), 24-35. PubMed
- Lee, P. A., Houk, C. P., Ahmed, S. F., & Hughes, I. A. (2006). Déclaration consensuelle sur la prise en charge des troubles intersexués. Pediatrics, 118(2), e488–e500. PubMed
- Lee, P. A., Nordenström, A., Houk, C. P., Ahmed, S. F., Auchus, R., et al. (2016). Mise à jour sur les troubles mondiaux du développement sexuel depuis 2006 : perceptions, approche et soins. Hormone Research in Paediatrics, 85, 158–180. OUCI
- Cools, M., Nordenström, A., Robeva, R., Hall, J., Westerveld, P., et al. (2018). Prise en charge des personnes présentant une différence du développement sexuel (DSD) : déclaration consensuelle. Nature Reviews Endocrinology, 14(7), 415–429. Nature

- Carpenter, M. (2018). Variations intersexuées, droits humains et Classification internationale des maladies. Health and Human Rights, 20(2), 205–214. PMC
- Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. (2016). Note d'information sur les violations des droits humains à l'encontre des personnes intersexuées. Genève : HCDH. HCDH
- Centre pour les droits de l'homme, Université de Pretoria. (2022). Protéger les droits humains des personnes intersexuées en Afrique. Pretoria : CHR. chr.up.ac.za
- GATE – Global Action for Trans Equality. (2022). Nous, les personnes intersexuées du Sud : édition Afrique. GATE | Global Action for Trans Equality
- Human Rights Watch. (2017). « Je veux être comme la nature m'a fait » : chirurgies médicalement inutiles sur des enfants intersexués aux États-Unis. Pulitzer Center
- Mouvement africain des personnes intersexuées. (2021). COVID-19 : Rapport sur la situation des personnes intersexuées en Afrique (rédigé par O. Chukwuike). https://www.intersexnigeria.org/pdfs/Covid-19%20Report%20AFRICA.pdf

Livres

- Karkazis, K. (2008). Fixing sex: Intersex, medical authority, and lived experience. Duke University Press. Duke University Press
- Swarr, A. L. (2023). Envisioning African Intersex: Challenging Colonial and Racist Legacies in South African Medicine. Durham, Caroline du Nord : Duke University Press. Duke University PressOAPEN Library
- Papillon, B. (2021). An Ordinary Wonder. New York, NY : Pegasus Books. (Protagoniste intersexué nigérian ; également publié par Dialogue Books au Royaume-Uni.) Simon & SchusterHachette UK
- Davis, G. (2015). Contesting intersex: The dubious diagnosis. New York University Press. NYU Press
- Reis, E. (2021). Bodies in doubt: An American history of intersex (2e éd.). Johns Hopkins University Press. press.jhu.edu
- Dreger, A. D. (1998). Hermaphrodites and the medical invention of sex. Harvard University Press. hup.harvard.edu
- Holmes, M. (Ed.). (2009). Critical intersex. Routledge. Routledge
- Zieselman, K. M. (2020). XOXY : A memoir. Jessica Kingsley Publishers.
- Semenya, C. (2023). The Race to Be Myself: A Memoir. New York, NY: W. W. Norton & Company. wwnorton.comReparations Club

L'ouvrage « Intégrer les perspectives intersexuées dans les politiques de santé pour une pratique inclusive au Nigéria » est un guide novateur de politiques et de pratiques conçu pour transformer les systèmes de santé en s'appuyant sur la dignité, l'autonomie et les droits humains. Fort de témoignages, des normes internationales relatives aux droits humains et d'années de plaidoyer, cet ouvrage offre des conseils pratiques aux professionnels de santé, aux décideurs politiques et aux organisations de la société civile qui souhaitent créer des environnements de soins inclusifs et respectueux des personnes intersexuées au Nigéria.

À travers une analyse factuelle, des témoignages authentiques de la communauté et des recommandations concrètes, ce guide remet en question les pratiques médicales néfastes et promeut une vision des soins de santé qui respecte l'autonomie corporelle et la diversité des caractéristiques sexuelles. Il constitue à la fois une ressource pour la réforme institutionnelle et un appel à l'action pour un système de santé plus juste et équitable au Nigéria.



À PROPOS DE L'AUTEUR

Obioma Chukwuike est le fondateur et directeur exécutif d'Intersex Nigeria et un défenseur de premier plan des droits humains des personnes intersexuées en Afrique. Il préside actuellement le conseil d'administration du Mouvement africain des personnes intersexuées (AIM) et contribue au plaidoyer mondial en faveur des personnes intersexuées par son rôle de leader au sein des instances régionales et internationales de défense des droits humains. Le travail d'Obioma est axé sur la justice en matière de soins de santé, la réforme des politiques et la mise en valeur des voix intersexuées à travers le continent.

intersex
NIGERIA
CENTER FOR HEALTHCARE DEVELOPMENT & YOUTH EMPOWERMENT

www.intersexnigeria.org